

Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo - Como lidar com o processo alimentar?

Principais pontos do tratamento

PARA PACIENTES COM TARE

JULIANA BERGAMO VEGA

Nutricionista, mestre e especialista em ciências aplicadas a pediatria e transtornos alimentares
Supervisora clínica e pesquisadora do Grupo de TARE do PROTAD/AMBULIM

Aula de hoje

1. Aspectos gerais sobre comportamento alimentar na infância e adolescência
2. Definições diagnósticas da recusa alimentar na infância e adolescência
3. Estudo de caso



O comportamento alimentar humano

- Processo sensoriomotor complexo, com estágios de desenvolvimento baseados em:

1. Maturação neurobiológica (intrínseco)

2. Experiências de aprendizagem (estímulos do ambiente)

- Não é instintivo: é um comportamento aprendido
- Mamíferos: altamente dependentes de um cuidador até a sua completa aquisição de habilidades para a autonomia alimentar
- Bebê humano: nasce sem sustentar o tronco (mais vulnerável e dependente do outro alimenta-lo em relação aos outros mamíferos)

(Ramsay,2004; Junqueira,2017)

Escolhas alimentares e seus determinantes

- Segundo Rosin, a escolha alimentar (no momento em que ela ocorre) é “apenas um passo em uma série de comportamentos organizados na busca por comida”
- Determinantes multidimensionais:
 - Individuais
 - Ambientais
 - Interpessoais
 - Políticos

Rosin P. The integration of biological, social, cultural and psychological influences on food choice. In: The Psychology of food choice. CABI Publishing; 2006, p.19-39

Symnank, et.al. Predictors of food decision making: a systematic interdisciplinary mapping, APPETITE, 2017

FUNÇÃO PRIMORDIAL: SOBREVIVÊNCIA DA ESPÉCIE

Alimentação como fenômeno multidimensional

Alimentação como
“zona de fronteira”



Múltiplos fatores de influência
Interagindo de forma sinérgica

Comemos para sobreviver ou sobrevivemos porque comemos?

- *AMBIVALÊNCIA NA RELAÇÃO COM O ALIMENTO E A SUA ESCOLHA:*
- As doenças transmitidas por alimentos (DTA) têm sido uma causa significativa de adoecimento e morte ao longo da história humana
- Apesar dos avanços, as DTA continuam a ser um problema de saúde global. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, anualmente:
- Cerca de 600 milhões de pessoas adoecem após ingerirem alimentos contaminados.
- Aproximadamente 420.000 pessoas morrem a cada ano devido a essas doenças.
- As crianças menores de 5 anos são as mais vulneráveis, representando 125.000 dessas mortes anuais.



Processo de escolhas alimentares: equilíbrio entre cautela e exploração

- Fatores de sucesso evolutivo

Adaptabilidade e flexibilidade: Somos "generalistas especialistas", capazes de viver em **uma ampla gama de ambientes e consumir uma variedade de alimentos**, como mostram evidências de adaptação do *Homo erectus* a climas extremos e o comportamento alimentar diversificado do *Homo sapiens*

Sobrevivência como espécie

- Desafios: atender as necessidades humanas básicas de sobrevivência em diversas condições climáticas e ambientais
- Mecanismos primitivos de sobrevivência
- Dilema das escolhas e decisões

Genoma humano: não muda há 50.000 anos

Alguns mecanismos biológicos primitivos de sobrevivência tem forte influência nas escolhas alimentares



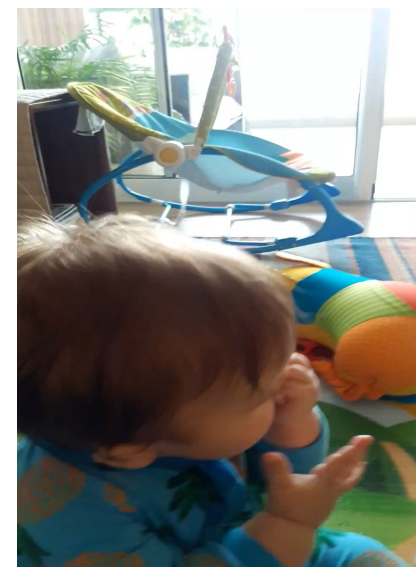


(Menella, Jagnow, Beauchamp, 2001)

- Alimentado pelo cordão umbilical
- Líquido amniótico aromático
- Influenciado pela alimentação maternal (experimento com alho ,aniz e suco de cenoura)



“Prepara a criança para a alimentação da família”



(Martin comendo limão)

Parte da evolução espécie humana

- **Doce**

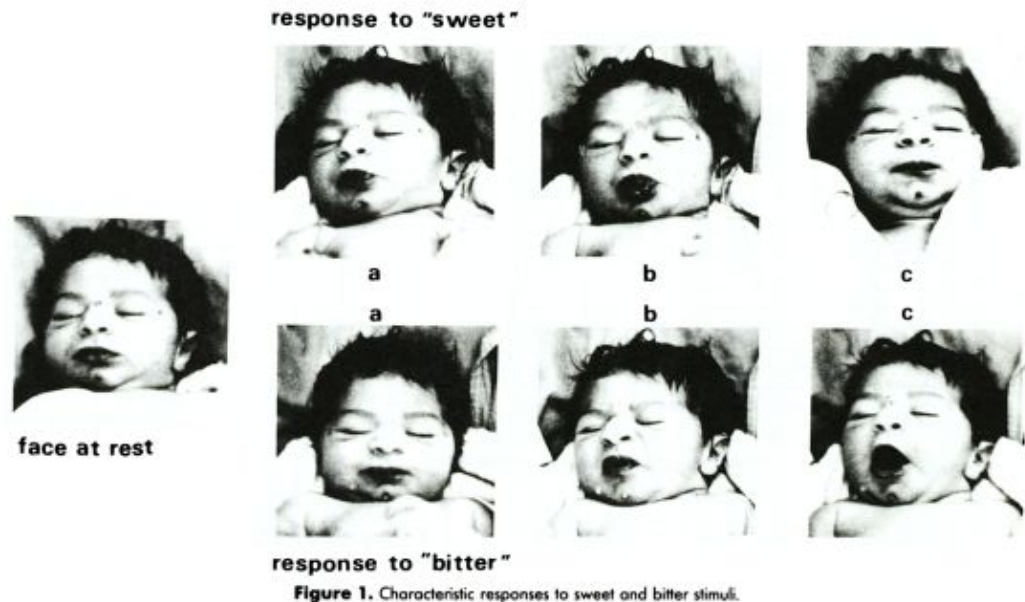
- Precoce(neonatos)e universal
- Reduz com o passar do tempo

- **Amargo**

- Aversão muito precoce
- Proteção contra intoxicação (plantas venenosas)

Mennela JA, et al. 2014.

Ganchrow JR et al., 1983. Infant Behav.



**PROGRAMAÇÃO BIOLÓGICA > PRAZER POR ALIMENTOS
ENERGÉTICOS**

amargo e azedo precisam ser aprendidos!

Somos mamíferos: a construção dos sabores



*“flavor
bridge”:
complexidade
de aromas da
dieta materna*

*Livre
demanda:
apoio à auto
regulação*

*Estímulo adequado
da musculatura
orofacial*



*Único
estímulo
sensorial*

*Normalmente
volumes e
horários
programados
e prescritos*

*Alterações
ortodônticas com
repercussões na
mastigação,
fonação, vedamento
labial*

(PETTY et.I., 2015; Brasil & Moares,2007; Mennella, 1995; Gonzalez, 2016; Costa,Romano,Moraes, 2008)

Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 54:1330–1341 (2014)
Copyright © Taylor and Francis Group, LLC
ISSN: 1040-8398 / 1549-7852 online
DOI: 10.1080/10408398.2011.635817



Brain Evolution, the Determinates of Food Choice, and the Omnivore's Dilemma

GEORGE J. ARMELAGOS

Department of Anthropology, Emory University, 1557 Dickey Drive, Atlanta, GA 30321, USA

Dilema do onívoro

Humanos comem de tudo → potencial nutricional e risco.

Maçã verde ou Mancenilheira?



hipoglicina A e pode causar sintomas graves, incluindo vômitos, diarreia, convulsões e até a morte

Jabuticabas ou louro-cerejeiro?



podem parecer apetitosas, mas também possuem toxinas perigosas, como o ácido cianídrico

Framboesas ou Bryonia dioica ?



Chamada popularmente de uva da serpente, é uma trepadeira cujos frutos e raízes contêm venenos fortes. Supõe-se que o óleo das sementes seja psicotrópico. Parente da abóbora e do melão.

Seletividade alimentar

- É tendência de consumir uma variedade inadequada de alimentos familiares (assim como novos), resultando em uma dieta habitual caracterizada pelo consumo de uma variedade particularmente baixa de alimentos.
- A quantidade inadequada também faz parte da seletividade

Neofobia alimentar

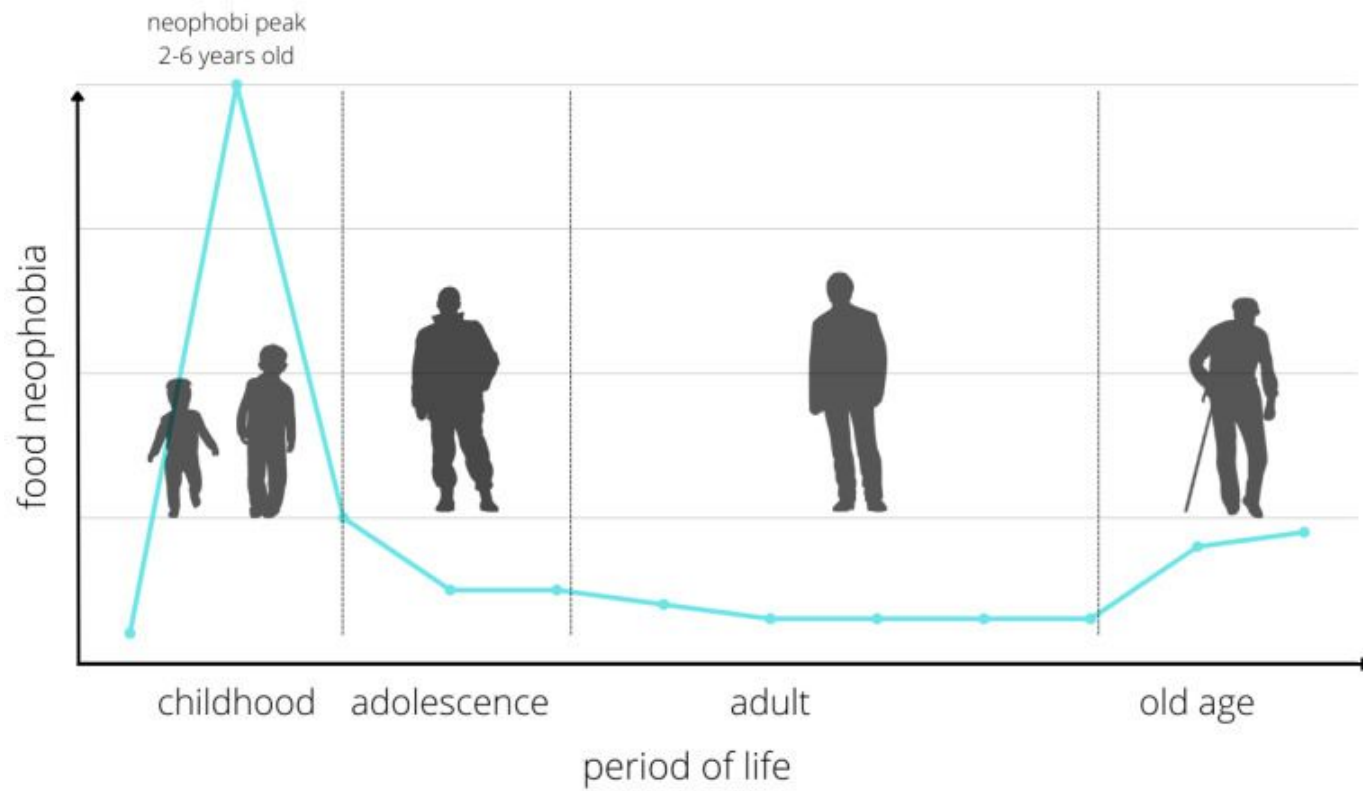
- É a tendência de rejeitar ou relutar em experimentar alimentos novos e desconhecidos.
- Pode ser em parte justificada pela seletividade alimentar

Terence M. Dovey, Paul A. Staples, E. Leigh Gibson, Jason C.G. Halford, Food neophobia and 'picky/fussy' eating in children: A review, *Appetite*, Volume 50, Issues 2–3, 2008, Pages 181-193

Białek-Dratwa A, Szczepańska E, Szymańska D, Grajek M, Krupa-Kotara K, Kowalski O. Neophobia-A Natural Developmental Stage or Feeding Difficulties for Children? *Nutrients*. 2022 Apr 6;14(7):1521. doi: 10.3390/nu14071521. PMID: 35406134; PMCID: PMC9002550.

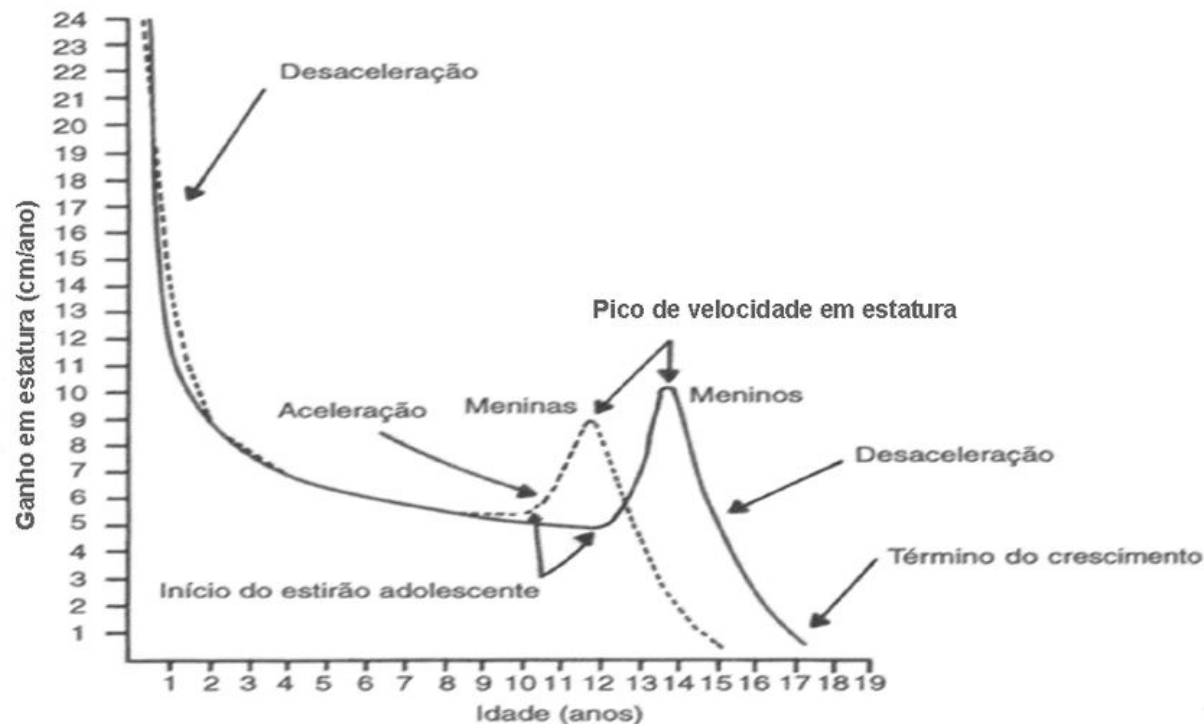
Neofobia alimentar

- A apresentação de um item novo, de qualquer tipo, pode desencadear uma resposta de medo (ou evitação) no indivíduo
- A rejeição **NÃO** ocorre durante a degustação do alimento — o que aumentaria o risco de envenenamento — mas acontece principalmente no domínio visual.
- Portanto, alimentos que não “parecem certos” para a criança serão inicialmente rejeitados apenas pela visão — por exemplo, vegetais verdes
- Crianças constroem *esquemas* de como um alimento aceitável deve parecer — e talvez cheirar —, e, portanto, alimentos que não se aproximam o suficiente desse conjunto de estímulos serão rejeitados. Essa rejeição pode ser extravasada para mais alimentos similares (pepino e aborinha, por exemplo)
- Forte influência genética
- Forte influência da fase de crescimento e desenvolvimento



crianças no primeiro ano de vida precisam de apenas uma exposição a um alimento novo para dobrar seu consumo

Velocidade de crescimento nas diferentes fases da infância e adolescência



Neofobia alimentar

- Se o alimento for reconhecido e aceito no domínio visual, ele será provado.
- O sabor será então avaliado quanto ao seu valor subjetivo (positivo ou negativo para o indivíduo) associado à imagem visual.
- Experiências positivas e contínuas com o alimento reduzirão a relutância da criança em consumi-lo. Por essa razão a pressão dos pais é contraproducente
- Aproximadamente 15 experiências positivas podem ser necessárias para que o alimento seja aceito e incorporado à dieta habitual da criança
- Incluir a diversão envolvida na preparação e no cozimento diminui a experiência do nojo. Alimentos apresentados de maneira positiva demonstraram ter maior probabilidade de serem aceitos

Alimento novo



Apenas ver
(pistas visuais)



Nojo
Tóxico



Rejeita/recusa
Experiência
emocionalmente
negativa



Ciclo da Neofobia alimentar
Toda vez que ver o alimento

Pressão dos
pais



Neofobia alimentar

- Alguns estudos sugerem maior prevalência em meninos
- Traços de personalidade influenciam: pessoas que “buscam sensações”, natureza e aventura são menos neofóbicos. Já traços de ansiedade, neurose, baixa abertura a novas experiências tendem a ser mais neofóbicos
- Facilitação social: Padrões de repetição que se tornam familiar (o maior número de pessoas entorno da criança que comem o alimento) diminui a neofobia. Uma única pessoa, tem efeito reduzido
- Observação dos outros tem maior efeito em relação a tentativas de convencimento mas é importante pensar em “como” essa exposição é feita

Seletividade alimentar

- O sabor e da sensação tátil dos alimentos é um dos fatores da seletividade, uma vez que essas crianças rejeitam inadequadamente certas texturas — algo que só pode ser plenamente determinado quando o alimento está na boca da criança.
- Associado a crianças que apresentam defensividade tátil e uma sensibilidade sensorial
- Deficiências nutricionais mais encontradas: Vitamina E, Vitamina C, ácido fólico e fibras (consumo reduzido de vegetais)
- Podem apresentar baixo peso
- Menor imunidade e maior problemas digestivos, que pode aumentar o desconforto ao comer (constipação e dor)
- Mais suscetíveis ao ambiente obesogênico: predileção por alimentos palatáveis como doces e ultraprocessados

Alimento novo

Prova o
alimento

Experiência
sensorial,
emocional e
física
desagradável

Rejeita/recusa
Reforça a experiência
emocionalmente
negativa

Ciclo da seletividade alimentar
Quando prova o alimento

Pressão dos
pais



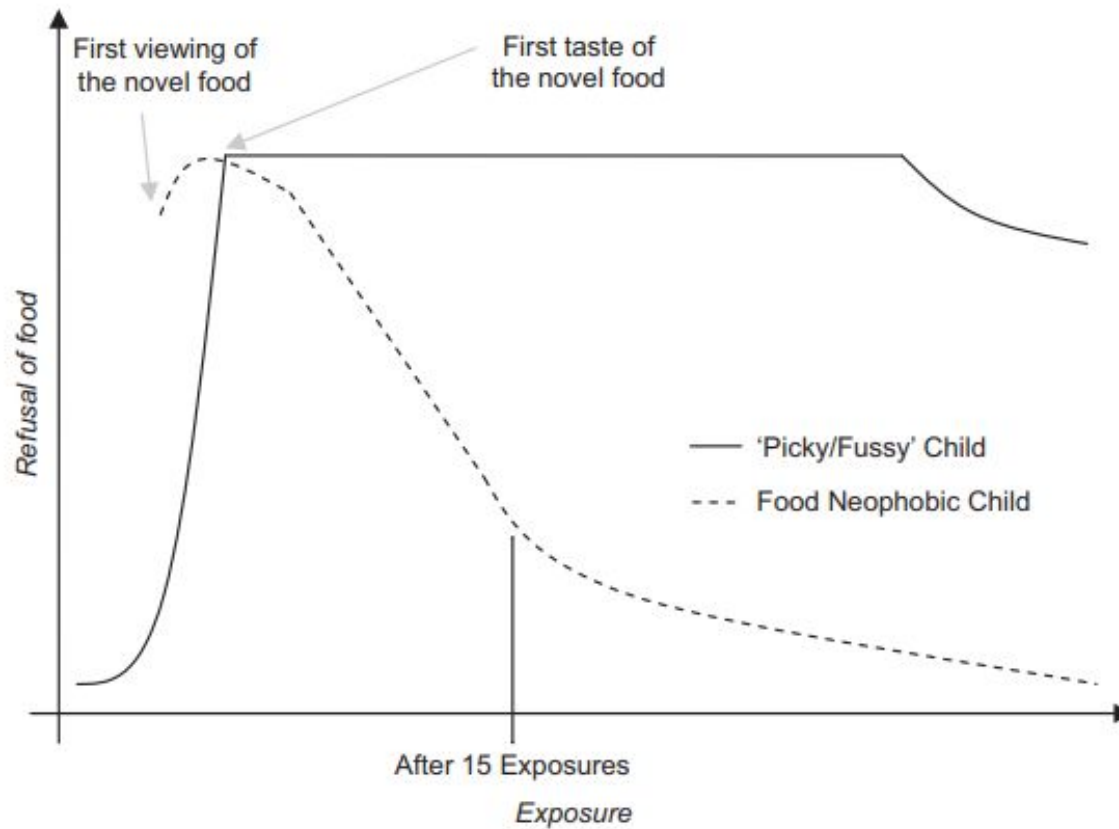


Fig. 2. Likelihood for acceptance of fruits and vegetables in food neophobic and 'picky/fussy' eating children.

Terence M. Dovey, Paul A. Staples, E. Leigh Gibson, Jason C.G. Halford, Food neophobia and 'picky/fussy' eating in children: A review, *Appetite*, Volume 50, Issues 2–3, 2008, Pages 181–193

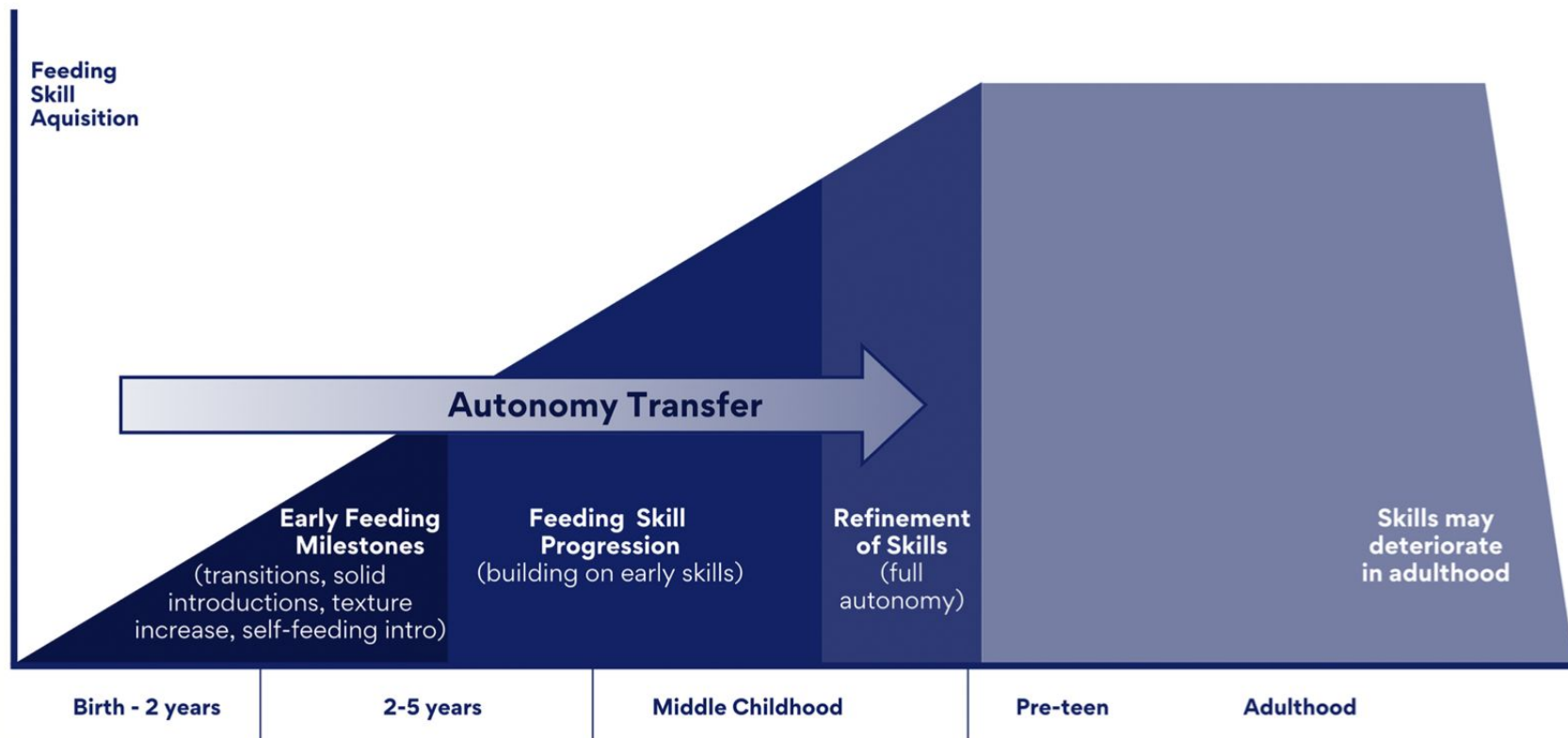


FIGURE 3 | Feeding development window.

Na vida adulta, fazemos cerca de 200 decisões sobre comida ao longo do dia. Qual a trajetória que devemos percorrer ao longo das fases de crescimento para nos tornarmos competentes para comer?

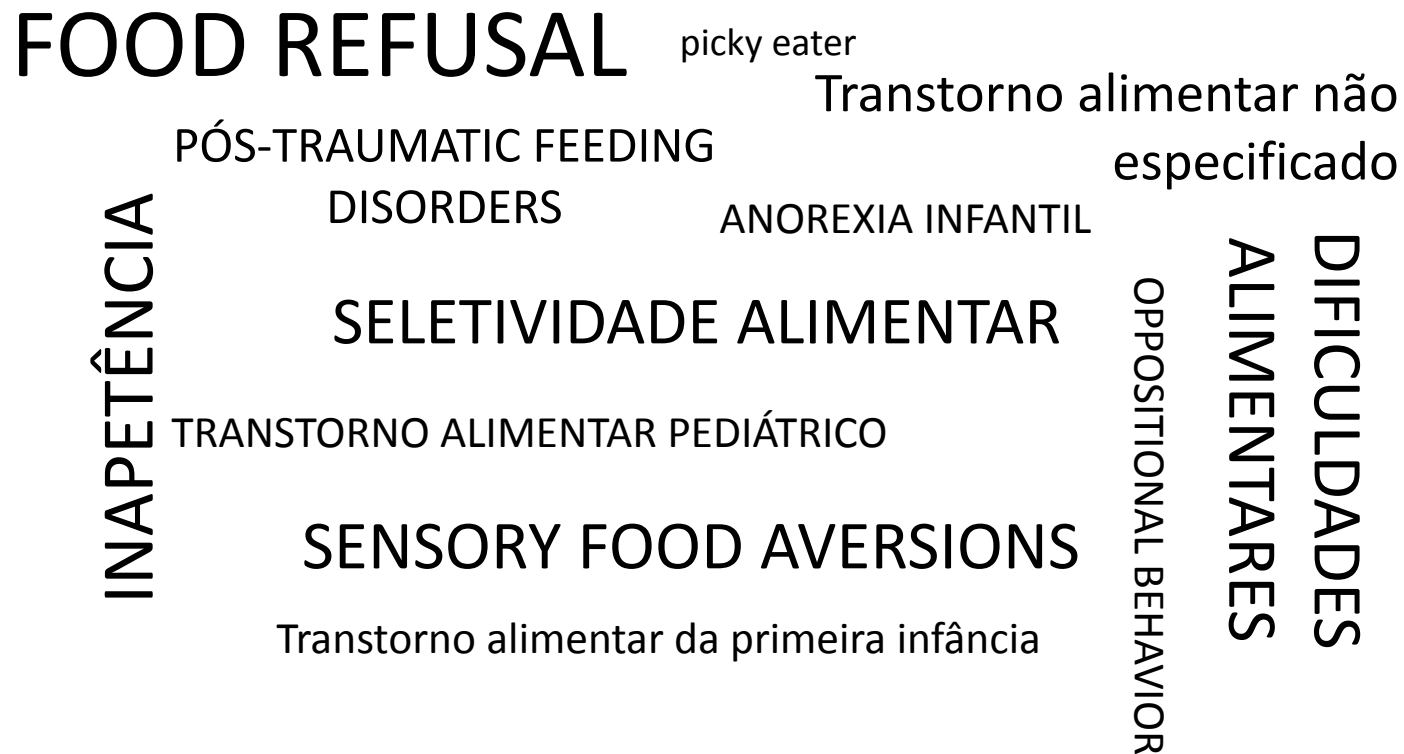
Quando a alimentação sai dos trilhos?

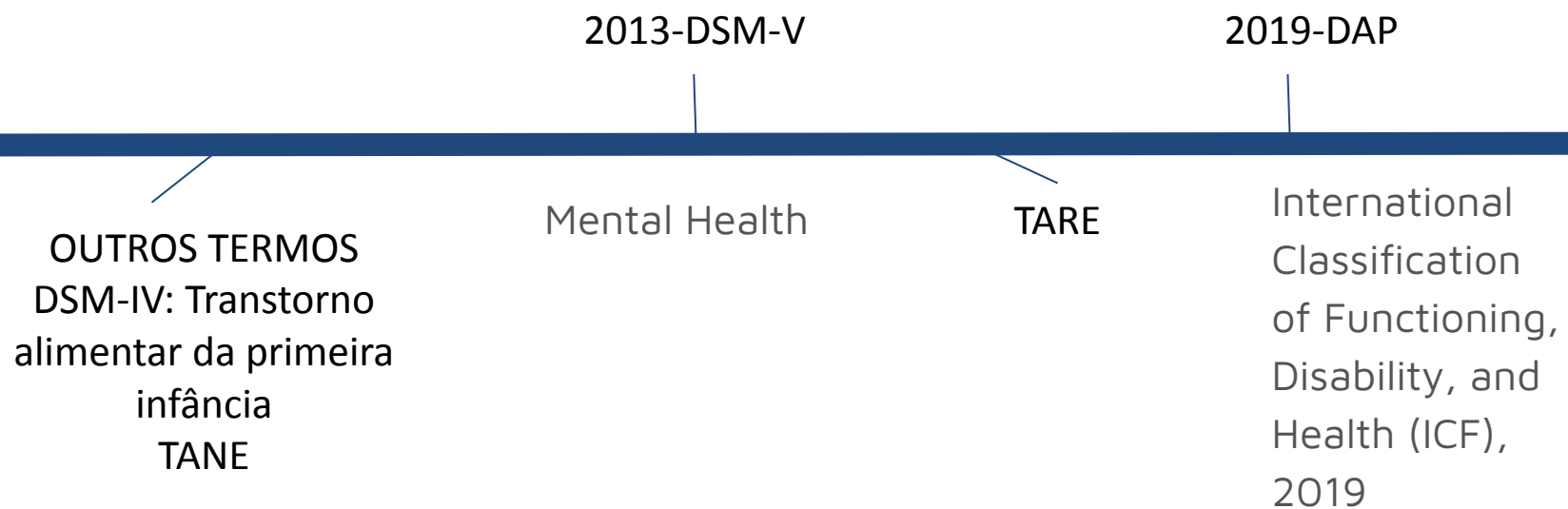


Conhecer o que é
“normal”
no crescimento e
desenvolvimento
infantil



BUSCADORES ANTES DO DIAGNÓSTICO



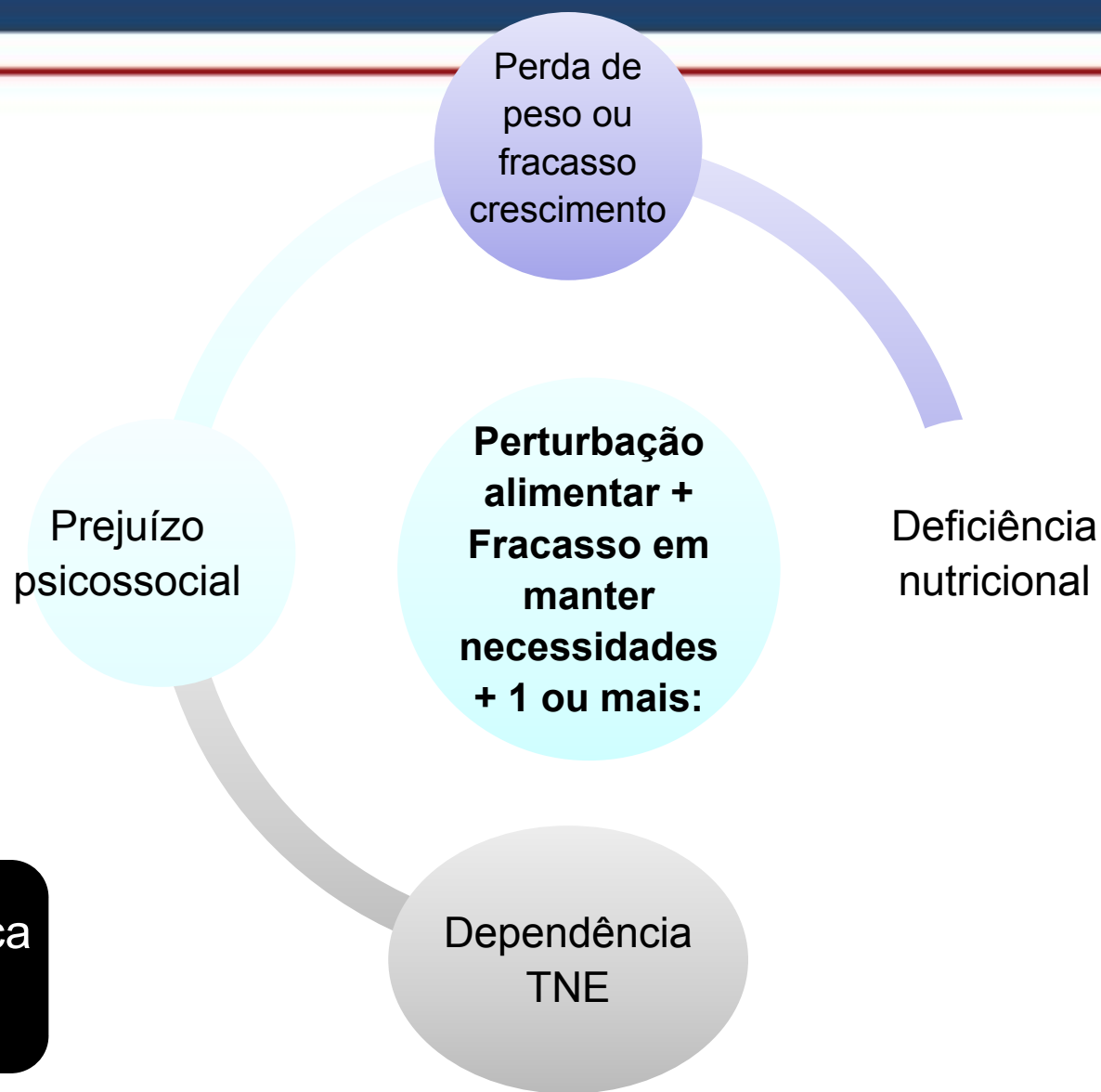


LINHA DO TEMPO DOS DIAGNÓSTICOS

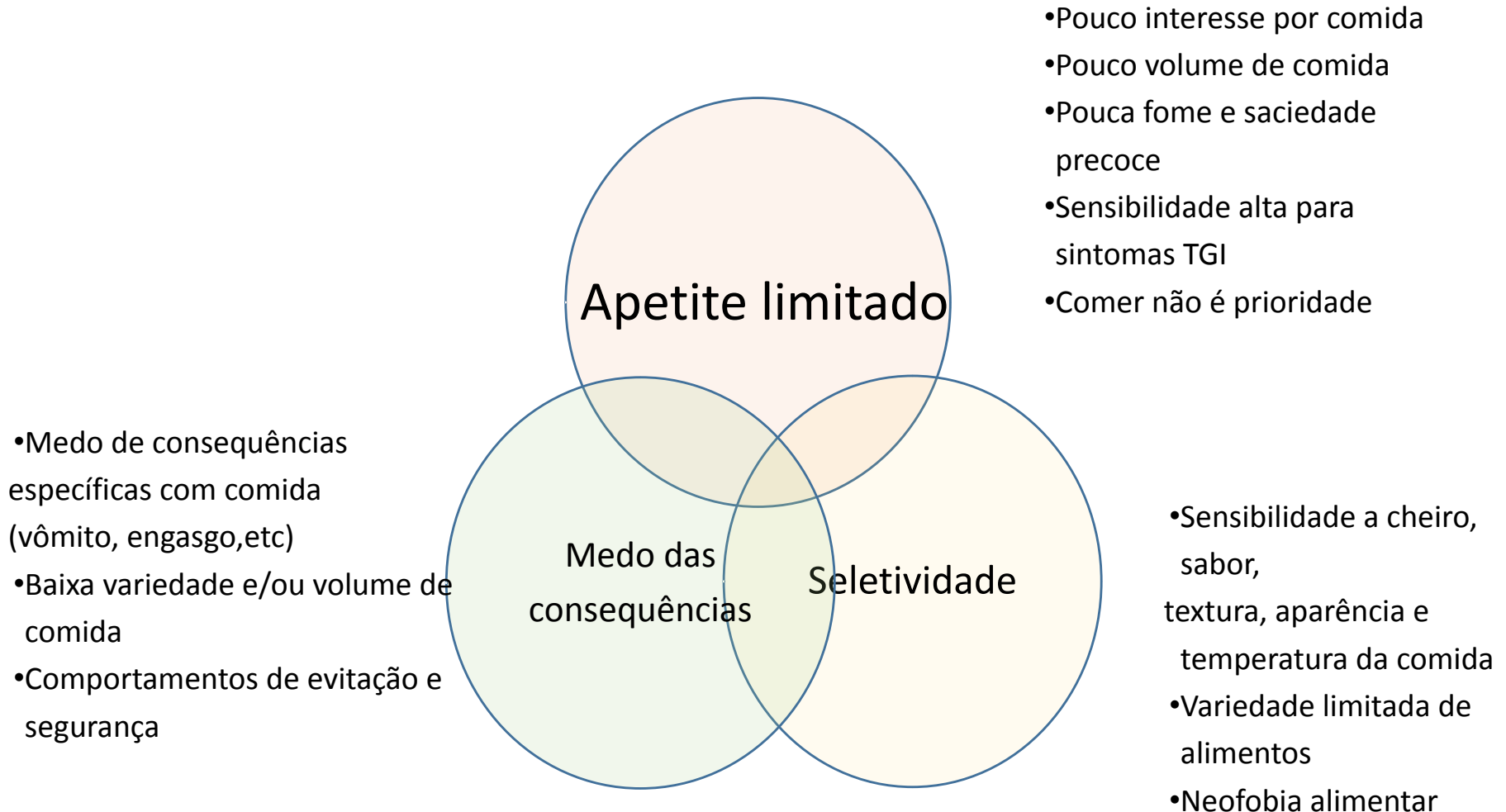
A. Uma perturbação alimentar (p. ex., falta aparente de interesse na alimentação ou em alimentos; esquiva baseada nas características sensoriais do alimento; preocupação acerca de consequências aversivas alimentar) manifestada por fracasso persistente em satisfazer as necessidades nutricionais e/ou energéticas apropriadas associada a um (ou mais) dos seguintes aspectos:

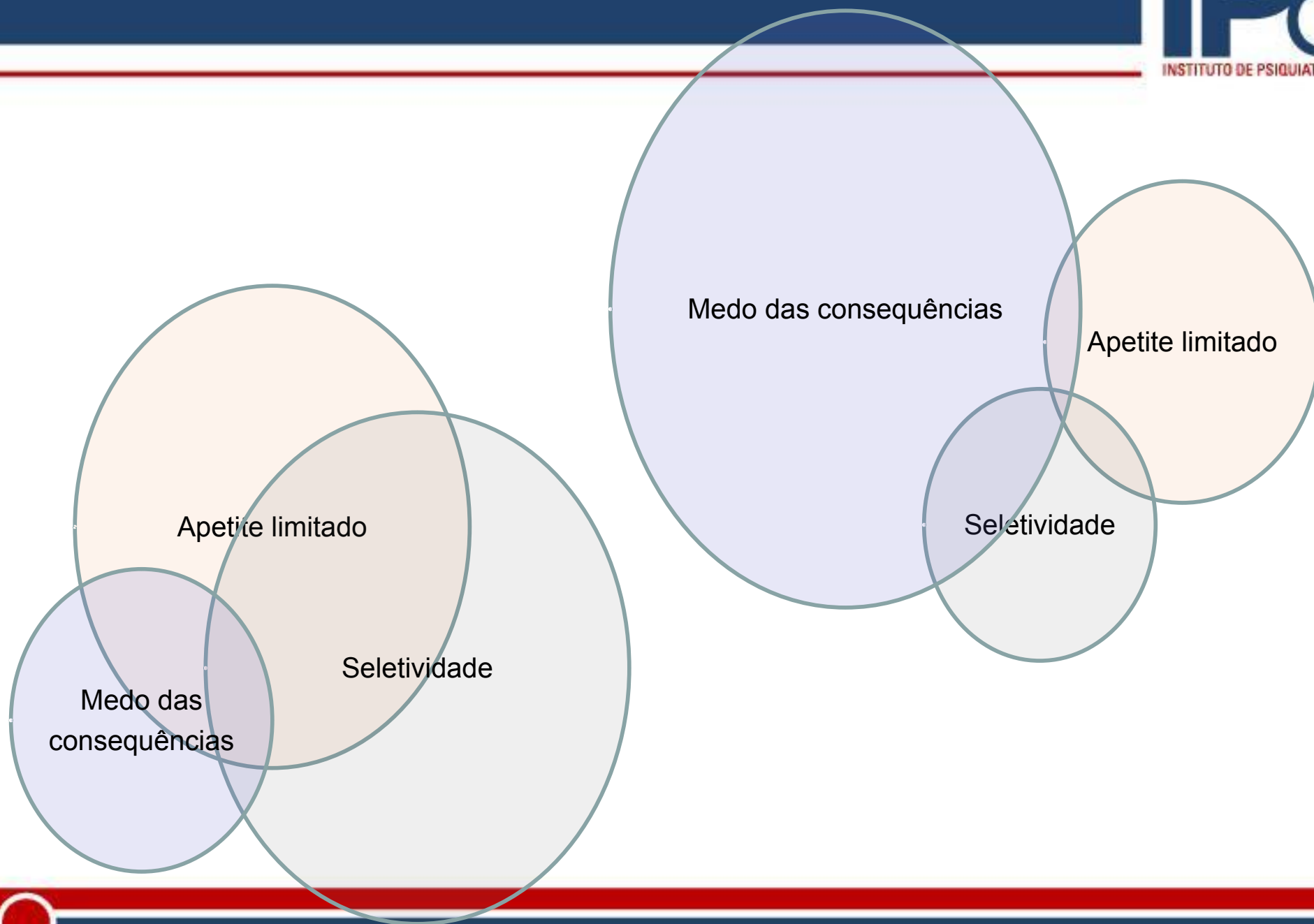
1. Perda de peso significativa (ou insucesso em obter o ganho de peso esperado ou atraso de crescimento em crianças).
2. Deficiência nutricional significativa
3. Dependência de alimentação enteral ou suplementos nutricionais orais
4. Interferência marcante no funcionamento psicossocial

Padrão alimentar associado a prejuízos clínicos e psicossociais

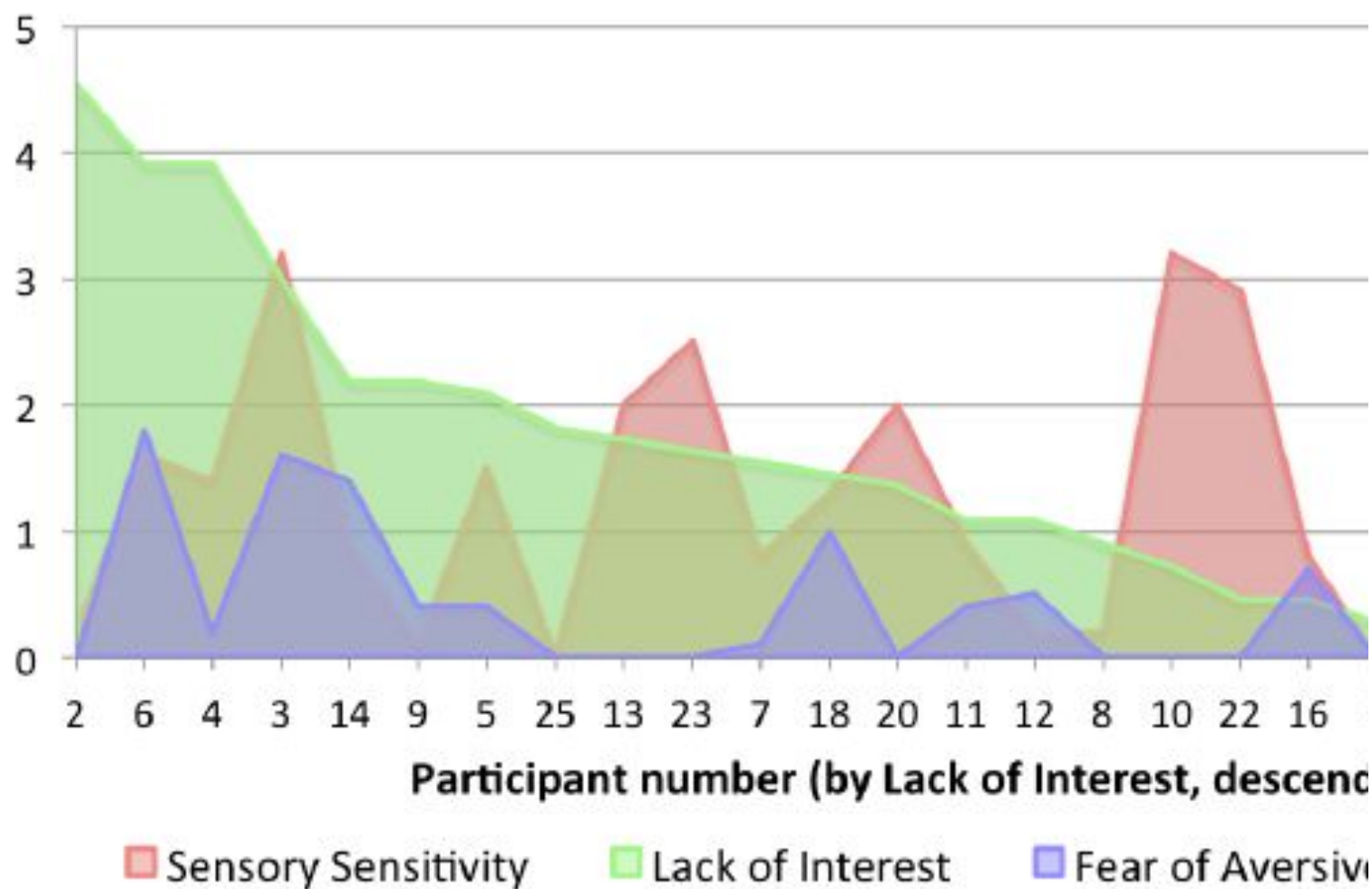


Apresentação clínica do TARE



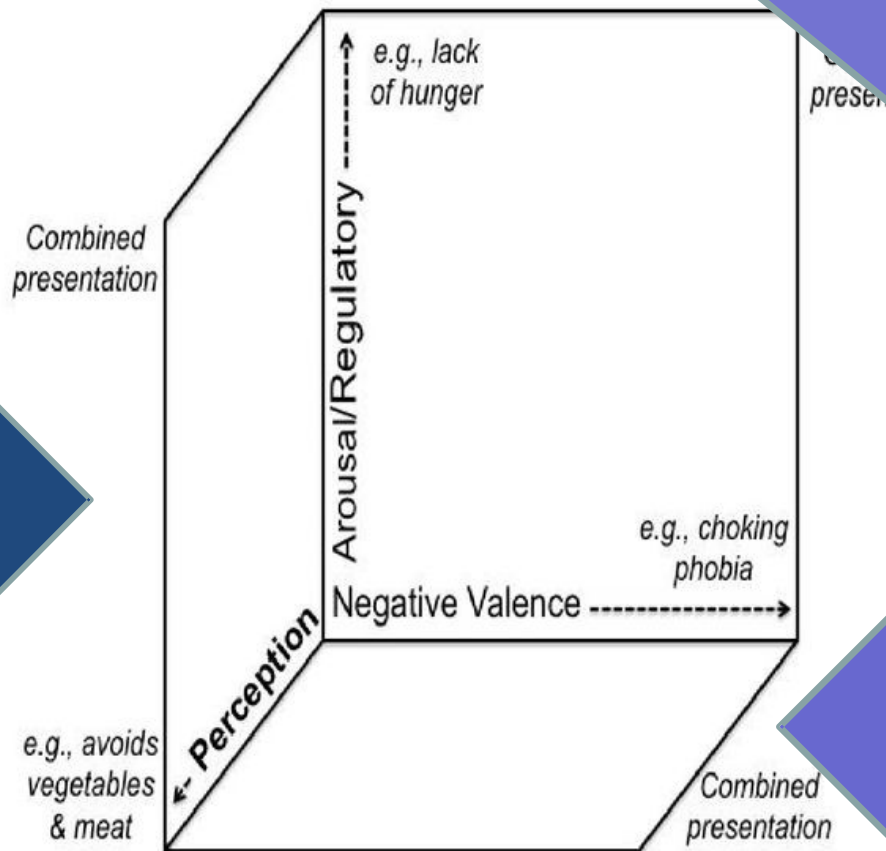


PARDI subscale score



1- Leve: aceita 3 alimentos de cada grupo mas aceitação mais concentrada em 1 grupo
 2- Moderado: Aceitou 1 alimento de cada grupo nas últimas 2 semanas
 3- Severa: rejeição completa de 1 ou mais grupos e aceita 5 ou menos alimentos

Figure 1b. Dimensional Model of Avoidant/Restrictive



1- Leve: Pula algumas refeições ou come pouco volume
 2- Moderado: Longos períodos em jejum ou pula a maioria das refeições
 3- Severa: Sem dieta oral (VIA ENTERAL)

1- Leve: 1 alimento devido a experiência traumática
 2- Moderado: exclui 1 grupo de alimentos devido a experiência traumática
 3- Severa: sem dieta oral ou apenas um número limitado de alimentos

- Processamento sensorial (hiper ou hiporesponsivos)
- Mecanismos interoceptivos
(saciedade precoce, ausência de fome e prazer)

- Nojo
- Mecanismos de luta e fuga

Sensorialidade

Intensidade da
resposta
neofóbica e
temperamento

Rigidez e inflexibilidade

Condições de
nascimento

- Baixo peso ao nascer
- IG
- Prematuridade
- TNE

Doenças
orgânicas

Genética

- Pais com seletividade
- Refluxo e esofagite
- Alergias alimentares
- TGI (constipação, doenças inflamatórias)

Prática
parental

- Pressão, punição, recompensa
- Clima de estresse durante as refeições
- Práticas de controle da permissividade
- Oferta limitada

Comorbidades
psiquiátricas

- Transtorno de ansiedade
- TDAH
- TEA
- Transt.do desenvolvimento

TARE

Pediatric Feeding Disorder (PDF) ou Distúrbio alimentar pediátrico (DAP), 2019

REVIEW ARTICLE: NUTRITION

OPEN

Pediatric Feeding Disorder—Consensus Definition and Conceptual Framework

**Praveen S. Goday, ^{††}Susanna Y. Huh, *Alan Silverman, [§]Colleen T. Lukens, ^{||}Pamela Dodrill, [¶]Sherri S. Cohen, *Amy L. Delaney, [#]Mary B. Feuling, **Richard J. Noel, ^{††}Erika Gisel, ^{‡‡}Amy Kenzer, ^{§§}Daniel B. Kessler, ^{||||}Olaf Kraus de Camargo, ^{¶¶}Joy Browne, and ^{##}James A. Phalen*

A. Uma perturbação na ingestão oral de nutrientes, inadequada para a idade, com duração de pelo menos 2 semanas e associada a 1 ou mais dos seguintes: AGUDO (≤ 3 MESES) OU CRONICO (> 3 MESES)

1. Disfunção médica, evidenciada por qualquer um dos seguintes

- a. Comprometimento cardiorrespiratório durante a alimentação oral
- b. Pneumonite aspirativa ou aspirativa recorrente

2. Disfunção nutricional, evidenciada por qualquer um dos seguintes

- a. Desnutrição
- b. Deficiência de nutrientes específicos ou ingestão significativamente restrita de um ou mais nutrientes resultante da diminuição da diversidade alimentar
- c. Dependência de alimentação enteral ou suplementos orais para manter a nutrição e/ou hidratação

3. Disfunção da habilidade de alimentação, evidenciada por qualquer um dos seguintes

- a. Necessidade de modificação da textura de líquidos ou alimentos
- b. Uso de posição ou equipamento de alimentação modificado
- c. Uso de estratégias de alimentação modificadas

4. Disfunção psicossocial, evidenciada por qualquer um dos seguintes

- a. Comportamentos de evitação ativa ou passiva da criança ao se alimentar ou ser alimentada
- b. Gestão inadequada das necessidades de alimentação e/ou nutrição da criança pelo cuidador
- c. Perturbação do funcionamento social num contexto alimentar
- d. Perturbação da relação cuidador-criança associada à alimentação

B. A ausência de processos cognitivos consistentes com transtornos alimentares e o padrão de ingestão oral não são devidos à falta de alimentos ou congruentes com normas culturais.

Quatro domínios principais fundamentam o PFD:

1.médico

2.nutricional

3. habilidades alimentares

4.psicossocial

Devido à interação entre esses domínios, uma disfunção em qualquer um deles pode causar prejuízos nos demais — resultando no desenvolvimento do PFD.

FORUM **OPEN ACCESS**

A US-Based Consensus on Diagnostic Overlap and Distinction for Pediatric Feeding Disorder and Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder

Hayley H. Estrem¹  | Jaclyn L. Pederson²  | Pamela Dodrill³  | Cuyler Romeo⁴  | Kelsey Thompson⁵  | Jennifer J. Thomas⁶  | Nancy Zucker⁷  | Richard Noel⁸ | Hana Zickgraf⁹  | Jessie Menzel¹⁰  | Colleen T. Lukens¹¹  | Praveen S. Goday¹²  | Sarah MacLaughlin¹³ | William G. Sharp¹⁴ 

- ARFID: 4 psicólogos
- PDF: dois psicólogos, dois pediatras, dois fonoaudiólogos e um terapeuta ocupacional

ARFID and PFD Diagnostic Overlap

KEY:  Central Feature  Included		ARFID	PFD
DOMAIN/POSSIBLE MANIFESTATION		DIAGNOSTIC CRITERIA	
NUTRITION			
Significant weight loss		✓	✓
Significant nutritional deficiency		✓	✓
Dependence on enteral feeding or oral formula supplementation		✓	✓
PSYCHOSOCIAL			
Food avoidance		✓	✓
Disruption in social function		✓	✓
Disruption in relationships		✓	✓
MEDICAL			
Cardiorespiratory compromise			✓
Aspiration			✓
Any medical disorder (impact on other domains)			✓
FEEDING SKILL			
Need for texture modification			✓
Use of modified feeding position or equipment			✓
Use of modified feeding strategy			✓
FEEDINGMATTERS.ORG			

FIGURE 1 | ARFID and PFD diagnostic overlap. Made available with permission from feeding matters organization.

- IDADE
- COMORBIDADES PSQUIÁTRICAS MAIS BEM DESCRITAS (TARE)
- Não há aprofundamento sobre a dupla cuidador-paciente (feedings disorders) no DSM

Queixa alimentar

Dificuldades alimentares

Inapetência

Seletividade

Medo de comer

Preenche critérios diagnósticos para o TARE?

Transtorno Alimentar



**MAS AFINAL, O QUE IMPEDE A CRIANÇA DE
COMER?**

- Comportamento alimentar: fatores individuais + ambientais
- A criança quer comer quando:
 - Conforto
 - Confiança
 - Conexão
 - Competência
- A investigação deve passar por todos os fatores que interferem nesses pilares

A large iceberg floating in the ocean. The tip of the iceberg is visible above the water surface, while the much larger, jagged base is submerged underwater. The sky is blue with some clouds.

A criança que não come

**Desafios do TARE:
GRUPO EXTREMAMENTE HETEROGÊNEO**



Dinâmica da alimentação

- Estilo parental (como os pais respondem a recusa alimentar)
- Temperamento

Ambiente alimentar

- Oportunidade de comer
- Acesso regular a variedade de alimentos
- Oportunidade de aprender

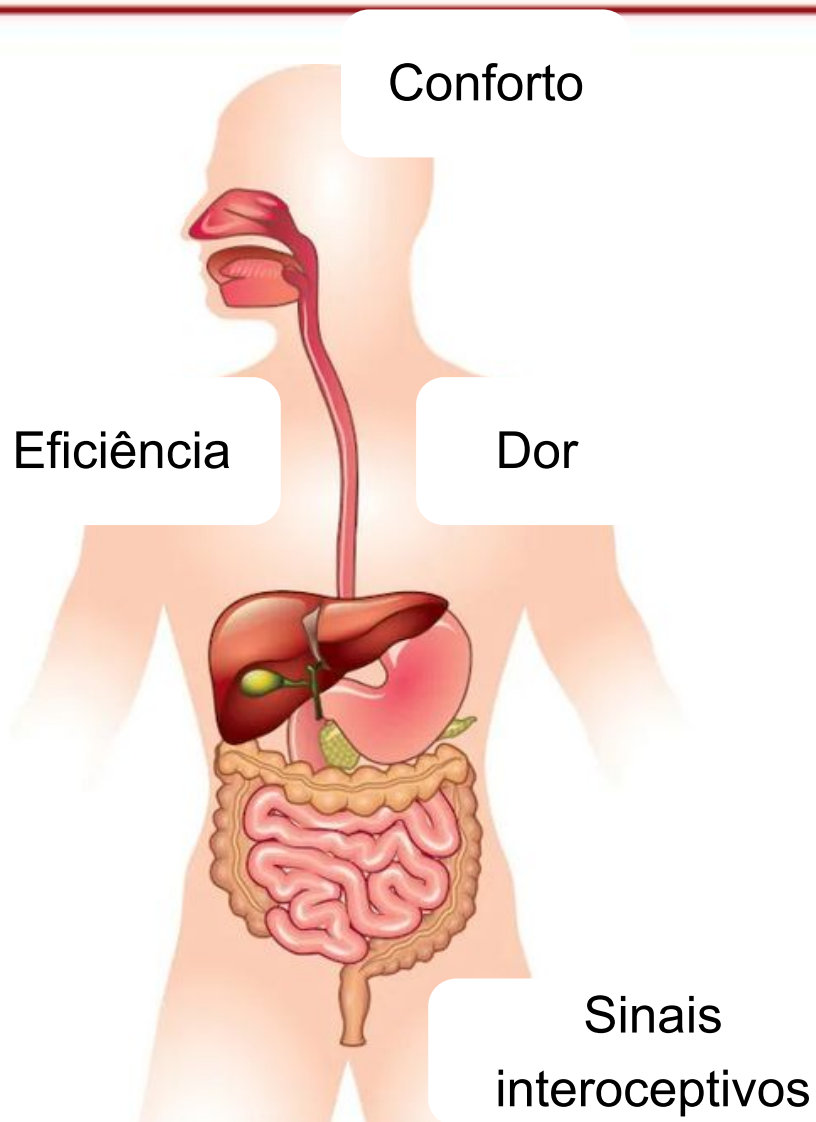
Causas orgânicas

- Motoras orais
- Processamento sensorial
- Histórico de doenças e comorbidades
- Estágios do desenvolvimento

Domínios do desenvolvimento relacionados ao comer (pré-requisitos):

1. Cognitivo
2. Motor oral
3. Interação e comunicação
4. Habilidades de auto alimentação
5. Aspectos sensoriais dos alimentos
6. Regulação do apetite

Descartar e/ou tratar as causas orgânicas



- Dificuldade de mastigar ou engolir
- Esofagite, gastrite, RGE
- Doença celíaca, D. Crohn, APLV e outras alergias
- Constipação
- Amigdalite, adenóide
- Transtorno do processamento sensorial
- Transtornos do neurodesenvolvimento
- Transtorno de ansiedade (TAG, A. separação, TOC)
- TDAH
- Outros Transtornos alimentares

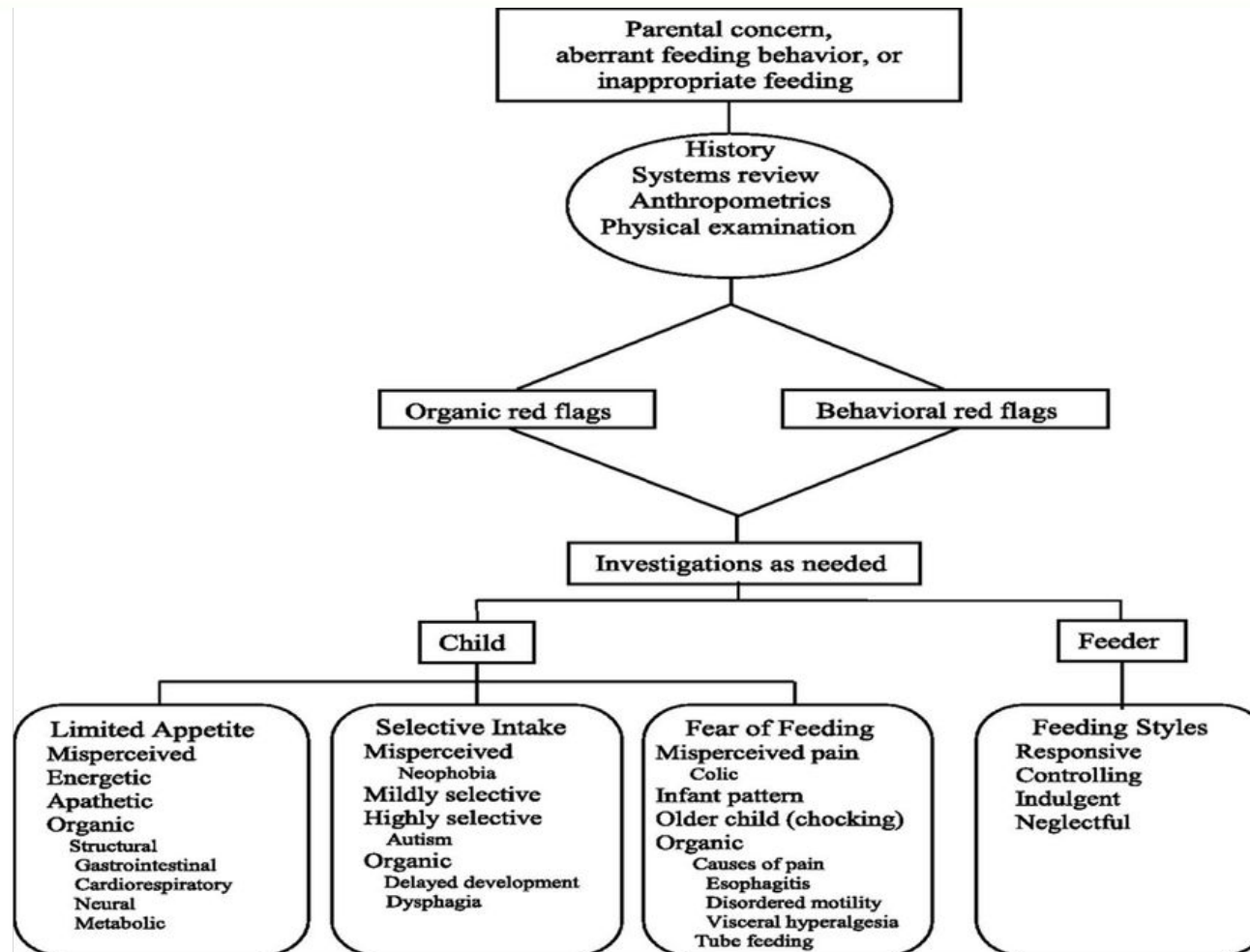
- Aproximadamente 20-15% das crianças com desenvolvimento típico
- Aproximadamente 80% das crianças com transtornos do desenvolvimento
- Pode estar associado a 204 tipos de diagnósticos clínicos
- Grupos de risco com maior prevalência: prematuros, uso de SNG, doenças do TGI, Transtorno de ansiedade, TEA, DI, TDAH

Prevalencia de Dificuldades Alimentares (DA)

- 30 a 45% das crianças são consideradas sele0vas pelos seus pais, em algum momento da infância (Dubois et al., 2007; Mascola et al., 2010; Cardona Cano et al., 2015)
- 14 e 50% nas crianças com idade pré-escolar (Carruth et al., 2004; Dubois et al., 2007)
- 5,6% e 27% crianças mais velhas (Marchi & Cohen, 1990; Micali et al., 2011; Tharner et al., 2014).

- Austrália: População adolescente e adultos 0,3% (Hay et.al., 2017)
- Switzerland:População de 8-13 anos 3,2%. TARE: maior a chance de ser baixo peso ou sobrepeso (Kurz et.al., 2015)
- EUA: População clínica centro gastropediatria americano 67% sexo masculino (Eddy et.al., 2015)
- Serviços médicos especializados 5% das crianças e 15% dos adolescentes (Norris et.al, 2014)
- Participantes de programa de hospital-dia para TA 22,5% em crianças e adolescentes de 7-17 anos (Nicely, et.al., 2014)
- Adultos em tratamento para TA no Japão: 8,9% (Tanaka et.al., 2015)

Investigação diagnóstica para DA



- **Sinais de alerta:**

- refeições prolongadas > 1 hora
- recusa alimentar por mais de 1 mês
- Evita situações que envolva alimentos de forma persistente (festas, viagem, casa de amigos, etc)
- Falta de independência para se alimentar
- Incapacidade de receber as necessidades nutricionais suficientes para adequado crescimento e desenvolvimento via oral
- Refeições: momento de muito estresse que pode interferir na relação entre pais e filhos
- Número limitado de alimentos aceitos, restrição de grupos alimentares
- Recusa de alimentos sólidos e/ou líquidos, texturas e consistências específicas

- DESAFIO: Diferentes manifestações de comportamentos alimentares problemáticos (origem da recusa alimentar diferente) em um mesmo diagnóstico

Por que tratar o TARE ?

- Desnutrição e complicações relacionadas
- Prejuízo permanente ao crescimento
- Prejuízo psicossocial
- Estresse e prejuízo a auto estima
- Associado a transtorno de ansiedade e a outros transtornos alimentares



Hay et al. *Journal of Eating Disorders* (2017) 5:21
DOI 10.1186/s40337-017-0149-z

Journal of Eating Disorders

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Burden and health-related quality of life of eating disorders, including Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), in the Australian population



Received: 11 March 2017 Accepted: 23 April 2017 Published: 4 May 2017

- Mental and Physical Health Related Quality of Life (M/PHRQoL) of participants with a DSM-5 eating disorder

Qualidade de vida e TARE

Table 4 Role Performance, Mental and Physical Health Related Quality of Life (M/PHRQoL) of participants with a DSM-5 eating disorder

	Days out of role Median IQ range	MHRQoL Mean ISD	PHRQoL Mean SD
Year assessed	2014	2015	2015
Anorexia Nervosa- Broad	0	46.9	53.6 ^{a,c}
	0-3	13.6	5.9
Bulimia nervosa (BN)	0 ^a	44.8 ^b	43.3 ^{b,c}
	0-4	10.9	12.8
BED-Broad	n.a.	39.2 ^b	42.1 ^b
		11.5	11.6
ARFID	4.0 ^a	38.7 ^b	53.8 ^c
	0-14	13.7	13.6
OSFED	n.a.	51.2	47.5
		8.8	11.6
Atypical AN	n.a.	51.5	48.4
		9.0	11.2
Sub-threshold BN	n.a.	50.2	49.0
		11.5	9.4
Sub-threshold BED	n.a.	51.1	49.9
		7.1	11.0
Purging Disorder	n.a.	38.5	39.3
		9.5	12.8
UFED	n.a.	51.8	50.3 ^{a,c}
		9.0	8.6
No eating disorder	0 ^b	52.8 ^a	48.7 ^{a,c}
	0-0	8.5	10.2

Data reported in this table are weighted for South Australian norms, *BED* Binge Eating Disorder, *OSFED* Other Specified Eating or Feeding Disorder, *UFED* Unspecified Feeding or Eating Disorder; data with differing superscripts

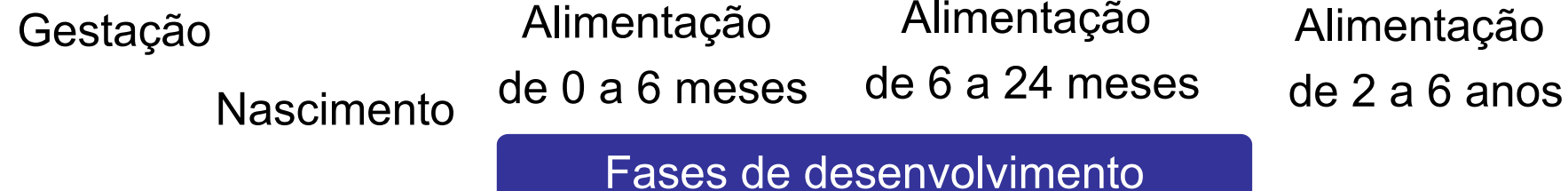
- Arfid: mesmas pontuações que AN
- Alto comprometimento da qualidade de vida e saúde mental, além dos riscos clínicos

ABORDAGEM TRANSDISCIPLINAR

- Para todos os profissionais:
- Investigação detalhada do histórico de saúde e da história de alimentação
- Lista completa (e detalhada) de alimentos aceitos
- Compreender a rotina de alimentação, estrutura e dinâmica das AVD
- Sinais de alerta para aspectos do desenvolvimento sensório-motor
- Observação direta da criança comendo

- Quando a alimentação da sua criança começou a te preocupar?
- Identificar períodos importantes de mudança de comportamento alimentar e peso (nascimento de irmão, separação dos pais, morte da família, mudança de cidade/escola, etc).
- Identificação de eventos abruptos, eventos traumáticos com a comida que aconteceu com a criança ou com alguém próximo a ela (engasgos, vômito, ser forçado a comer, internações)

História da doença vs tempo (cronologia)



Lista de aceitação alimentar

Aceita (Sim/Não) Já experimentou (Sim/Não) Gostou (Sim/Não)

CARNE, PEIXE, FRANGO

Hambúrguer de lanchonete			
Hambúrguer caseiro			
Quibe			
Carne moída			
Almôndega			
Bife			
Carne picada			

Nuggets

Frango desfiado			
Filé de frango frito/grelhado			
Coxa de frango			
Sobrecoxa de frango			

Peixe empanado

Peixe grelhado			
Peixe assado			
Salmão grelhado/assado			

PREPARAÇÕES MISTAS

Pizza			
Lasanha			
Coxinha			

"CREMES" E MOLHOS

Manteiga ou margarina			
Requeijão			
Geleia			
Nutella			
Polenguinho			
Ketchup			
Molho branco			
Shoyu			
Pães e salgados			

Aceita (Sim/Não) Já experimentou (Sim/Não) Gostou (Sim/Não)

ARROZ, CEREAIS, BATATA, RAÍZES, TUBÉRCULOS E MASSAS

Arroz branco			
Miojo			
Macarrão sem molho			
Macarrão com molho de tomate			
Batata frita			
Batata assada			
Purê de batata			
Batata cozida			
Mandioca frita			
Mandioca cozida			
Milho verde			

BEBIDAS

Leite:			
Iogurte:			
Suco de caixinha:			
Suco de fruta:			

PÃES E SALGADOS

Pão francês			
Bisnaguinha			
Pão de forma			
Pão de queijo			

BISCOITOS E SALGADINHOS

Maisena/Club Social:			
Biscoito recheado:			
Cookie:			
Sucrilhos, Nescau cereal, etc:			
Salgadinho:			

FRUTAS QUE ACEITA:

VERDURAS E LEGUMES QUE ACEITA:

Ativar o V

- **Vídeo da criança se alimentando: COMO É ALIMENTADA**
- comportamento da criança, conforto, postura, mordida, vínculo com o cuidador, comportamento dos pais, texturas oferecidas
- Qual o “clima” das refeições?
- Tempo de duração da refeição?

A importância do contexto



Ciclo mantenedor da recusa alimentar



(Adaptado: Rowell & MacGlothin, 2015)

Ciclo mantenedor da recusa alimentar



(Adaptado: Rowell & MacGlothin, 2015)

Quem é o paciente que eu vou atender?

- Qual a queixa?
- Escuta ativa, cuidadosa e empática





- Plano terapêutico centrado na criança
- Saúde e desenvolvimento de forma integral
- Intervenções com múltiplas estratégias
- Equipe Transdisciplinar
- Olhar além da queixa

Equipe transdisciplinar

Psiquiatra Psicólogo
Ter. familiar Fonoaudiólogo Outras especialidades

Conhecimento sobre TARE

Pediatra
Gastropediatra

Nutricionista

Terapeuta ocupacional

PA
CI
EN
TE

Papel de cada especialista da equipe

Psiquiatra	Diagnóstico TA, comorbidades psiquiátricas, diagnósticos diferenciais tratamento medicamentoso, orientação parental, encaminhamentos para especialistas
Gastropediatra	Investigação clínica para descartar e/ou tratar causas orgânicas, avaliação global da saúde da criança
Nutricionista	Avaliação do estado nutricional Identificação das deficiências nutricionais Prescrição dietética de acordo com as habilidades e tolerâncias individuais Orientação parental focado no ambiente alimentar Desafios alimentares para ampliação do repertório

Fonoaudiologa	Avaliação das habilidades motoras orais que interferem na eficiência em comer Terapia de aproximação dos alimentos Orientação para adaptação de cardápio frente a tolerância dos pacientes
Psicólogo	Avaliação dos prejuízos psicossociais do paciente e da família Identificação dos fatores mantenedores Apoio aos sentimentos e crenças disfuncionais sobre alimentação Terapia familiar para desarticulação da dinâmica alimentar disfuncional
Terapeuta ocupacional	Avaliação do perfil sensorial Investigação e intervenção do TPS Orientação para adaptação de cardápio frente a tolerância dos pacientes Avaliação e intervenção funcional quanto as atividades de vida diária

Estabilidade clínica

- Avaliação da necessidade de internação hospitalar
- Estratégias de recuperação do estado nutricional
- Investigação e tratamento de comorbidades clínicas que impeçam a alimentação adequada

Mecanismos mantenedores

- O que mantém a recusa alimentar?

Identificação do ciclo perpetuador da recusa alimentar

Alinhar expectativas dos pais

Intervenções para redução de estresse

Autonomia alimentar

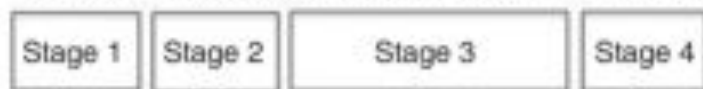
- Aplicação das estratégias de enfrentamento
- Habilidades alimentares
- Ampliar conforto, repertório e autonomia alimentar

- Melhorar sintomas clínicos e corrigir deficiências nutricionais
- Melhorar ambiente e dinâmica alimentar
- Instrumentalizar os pais a dar continuidade a exposição após o fim do tratamento, além da assertividade da resposta frente à recusa do paciente
- Aceitação alimentar de um numero mínimo de alimentos dos principais grupos alimentares
- Redução dos prejuízos psicossociais

- FBT Family based treatment for ARFID
- CBT- AR Cognitive behavior therapy for ARFID
- Técnica do *Food chaining* (dessensibilização sistemática)
- Técnicas *Interoceptive exposure*
- Terapias comportamentais (baseado em tratamento para TEA)

CBT- AR FOR ARFID

1 mecanismo mantenedor sem necessidade de recuperação nutricional



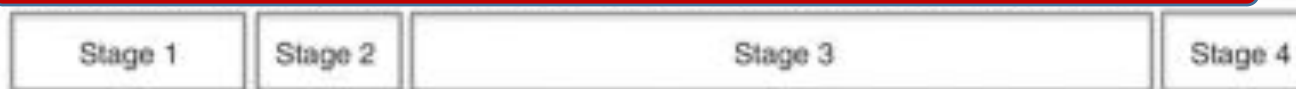
Enfrentamento do
mecanismo mantenedor

2 mecanismos mantenedores sem necessidade de recuperação nutricional



Enfrentamento dos 2 mecanismos
mantenedores por ordem de prioridade

3 mecanismos mantenedores com necessidade de recuperação nutricional



Tempo adicional para
Rec. nutricional

Enfrentamento dos 3 mecanismos
mantenedores por ordem de prioridade

Session 1

Session 20

Session 30

Thomas & Eddy, 2019

Fases	Intervenções
Fase 1 (2-4 SESSÕES)	1. Psicoeducação TARE e TRATAMENTO 2. Auto monitoração (criança ou pais) 3. Padrão regular de refeições 4. Aumento de volume (BAIXO PESO) 5. Variedade alimentar (todos) 6. Individualização do funcionamento do TARE por subtipo
Fase 2 (2 SESSÕES)	7. Continuar aumentando volume e variedade 8. Avaliação dos grupos alimentares com o paciente
Fase 3 (14-22 SESSÕES)	9. Dessensibilização sistemática de novos alimentos (durante a sessão fazer a exploração sensorial) 10. OU : Psicoeducação sobre ansiedade, Lista hierárquica de medo, enfrentamento gradual durante a sessão 11. OU: Mecanismos interoceptivos (saciedade precoce, náusea, empachamento) exposição a alimentos de preferência
Fase 4 (2 SESSÕES)	12. Identificar estratégias em casa para manutenção dos ganhos, de como lidar com os novos alimentos e com os desafios de peso

CBT – Estruturado em sessões (até 30 sessões) e fases (4)
Psicoeducação grupo de pais (BASEADOS NO SPACE)
Grupo de crianças com TO e fono
Atendimento individual psiquiatria e nutrição semanal

CBT SPACE	CBT SPACE	CBT SPACE
FBT para manejo de recuperação nutricional em desnutridos	Dessensibilização sistemática (food chaining)	•Lista hierárquica de alimentos •Técnicas de exposição gradual
Interosceptive exposure Estímulo a percepção de mecanismos interoceptivos	Terapias comportamentais (exposição com recompensa)	

Qualquer conduta terapêutica realizada em pacientes com ARFID deve ser coerente e adaptada tanto à sua idade, tendo em conta o desenvolvimento da criança, como à gravidade da evolução da doença.

Uma parte fundamental da terapia é a cooperação com os pais ou cuidadores do paciente e na definição dos objetivos e expectativas de cada parte

CONCLUSÕES FINAIS

- O plano de tratamento é baseado no subtipo apresentado e no estado nutricional do paciente
- O foco principal é minimizar os prejuízos clínicos
- As terapias de exposição devem ser cuidadosamente planejadas, não devem ser feitas de forma aleatória
- Metas de tratamento: não mais preencher os critérios diagnósticos para TARE ou diminuir gravidade, num de alimentos dos principais grupos alimentares e melhora dos prejuízos psicossociais
- Um foco importante do tratamento é desarticular o funcionamento do mecanismo mantenedor da recusa alimentar

Obrigada!

Juliana Bergamo Vega

@papos_e_pettyscos

@paposdepapas

Estudos de caso de Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo (TARE)

Juliana Bergamo Vega

Grupo de atendimento à crianças e adolescentes com TARE

PROTAD/AMBULIM

2023

RECUSA ALIMENTAR

NORMAL DA
IDADE?

DIFICULDADE
ALIMENTAR?

TARE?

FRESCURA?



Caso clínico 1

- FNS, 7 anos, sexo feminino, irmã mais nova (irmão 12 anos), mora com os pais e vizinha dos avós paternos
- **Queixa: sempre aceitou poucos alimentos, mas desde que leu a notícia que uma criança engasgou com salsicha e morreu, parou de comer alimentos coloridos.**
- Estuda período integral das 8h as 16h
- Escola se queixa de falta de atenção e apatia, não tem motivação para aulas de AF

Quais são os primeiros questionamentos?

- Será um caso de TARE ou um comportamento alimentar esperado para a idade?
- A recusa alimentar dela pode ser justificada por outra causa clínica? Dor ou desconforto?
- A recusa alimentar dela a coloca em risco clínico ou nutricional?
- Quais os outros prejuízos?

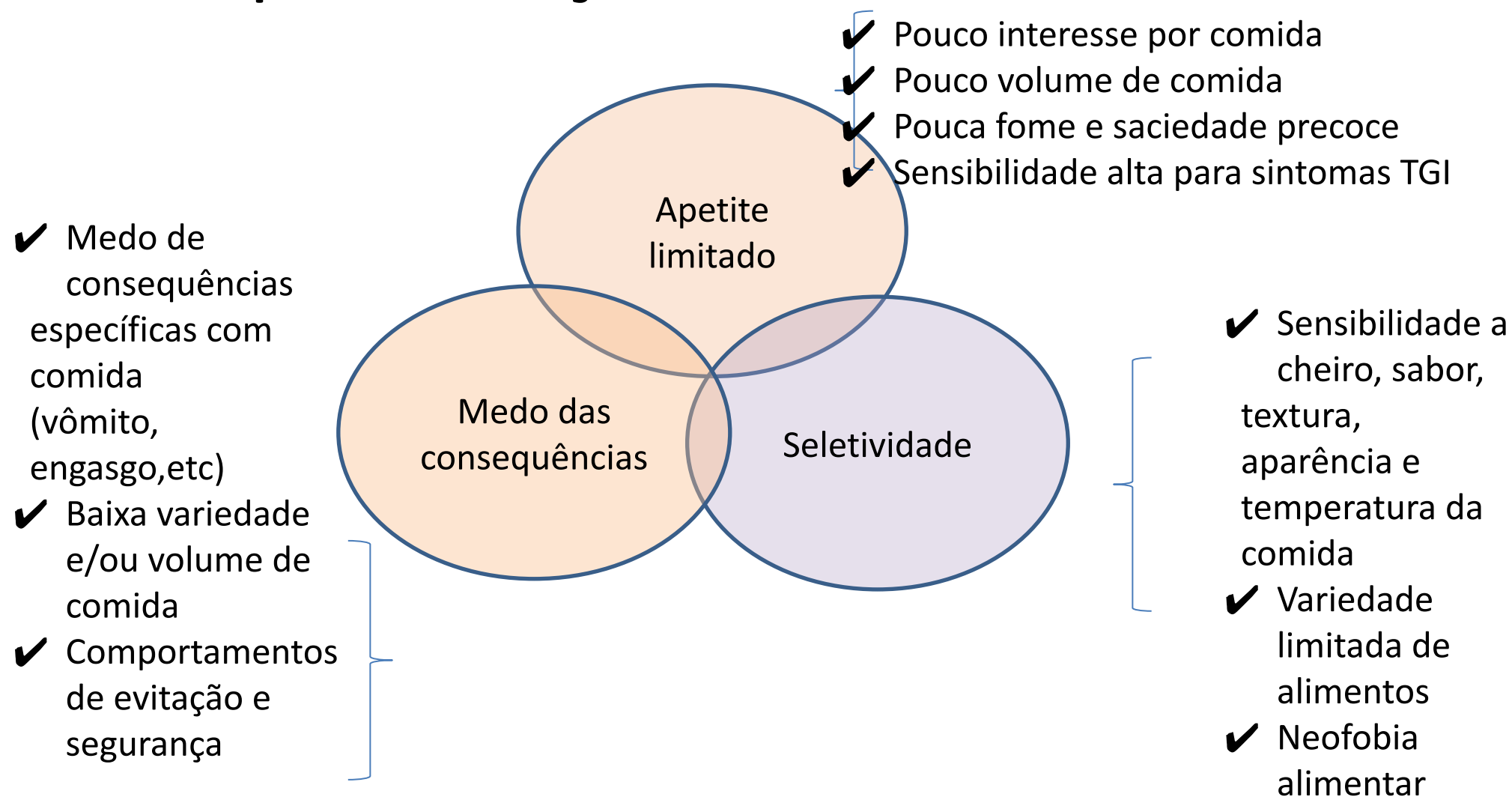
TARE-Critérios diagnósticos

A. Uma perturbação alimentar (p. ex., falta aparente de interesse na alimentação ou em alimentos; esquiva baseada nas características sensoriais do alimento; preocupação acerca de consequências aversivas alimentar) manifestada por fracasso persistente em satisfazer as necessidades nutricionais e/ou energéticas apropriadas associada a um (ou mais) dos seguintes aspectos:

1. Perda de peso significativa (ou insucesso em obter o ganho de peso esperado ou atraso de crescimento em crianças).
2. Deficiência nutricional significativa
3. Dependência de alimentação enteral ou suplementos nutricionais orais
4. Interferência marcante no funcionamento psicossocial

Padrão alimentar associado a prejuízos clínicos e psicossociais

Apresentação clínica do TARE



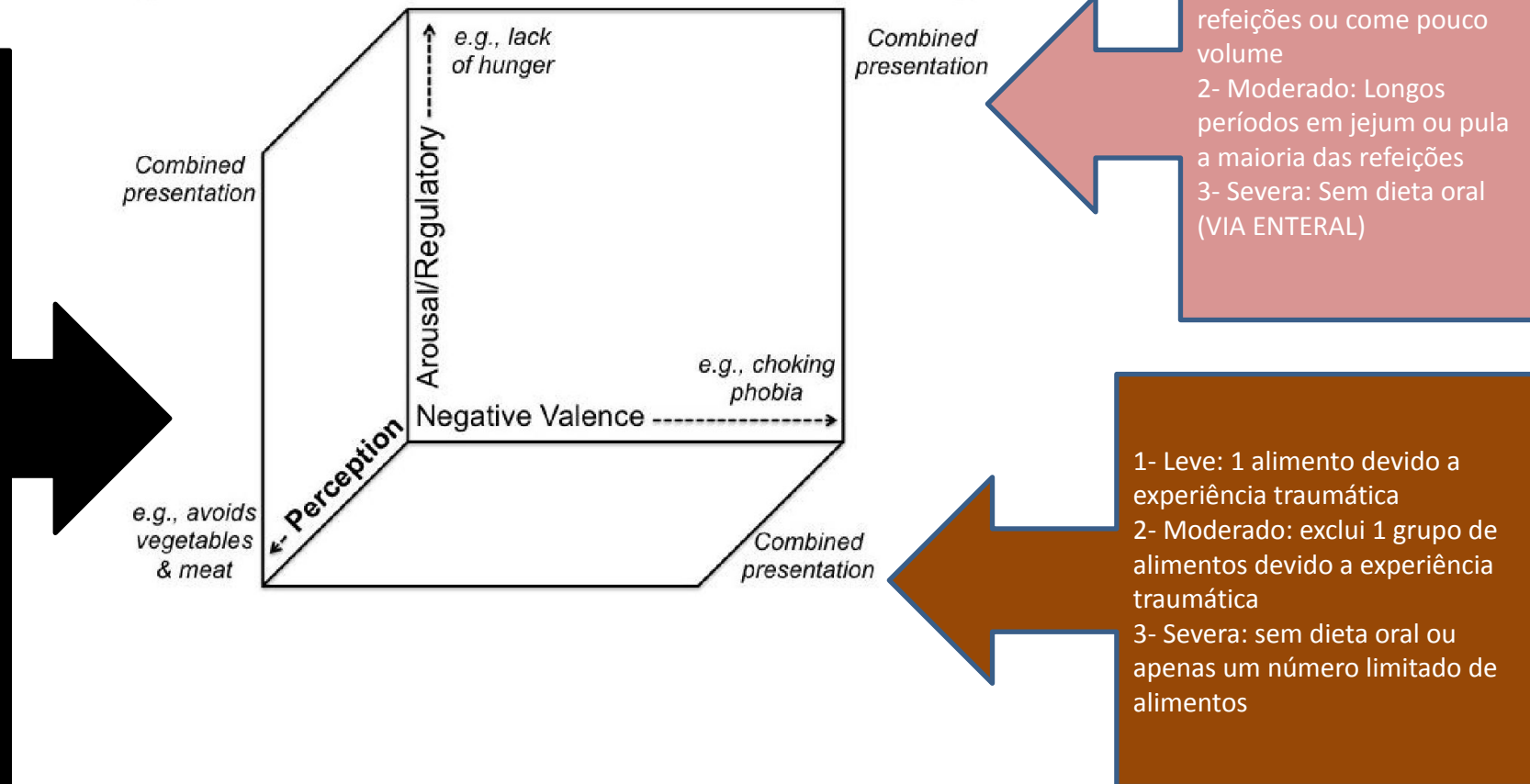
(Thomas & Eddy, 2019, adaptado ICED 2020)

- Aceitação alimentar atual: aceita apenas omelete, panqueca, biscoito de polvilho, salgadinho (cheetos) suco de pêssago (apenas de 1 marca), água, chocolate branco

Rotina alimentar do final de semana

- 10h- Panqueca $\frac{1}{2}$ porção + água 2 copos (em casa)
- 13h - omelete 3 quadradinhos + suco de pêssgo 3 copos (em casa, em frente a TV)
- Beliscou chocolate durante a tarde
- 16h – mãe ofereceu lanche recusou
- 18h – panqueca $\frac{1}{3}$ porção + 3 copos de suco de pêssgo (no quarto, fazendo lição)
- 1 copo de suco de pêssgo + chocolate antes de dormir
- Não faz refeições à mesa com a família pois faz birra, chora muito. Pais acabam permitindo que ela coma onde quiser. Durante a semana ela aceita menos alimentos e gasta mais energia. Mãe se preocupa muito. Refere que a menina bebe muito líquido durante a refeição, parece que não suporta comer, como um sacrifício

Figure 1b. Dimensional Model of Avoidant/Restrictive Eating



Thomas et al., 2017

FNS, 7 anos, sexo feminino

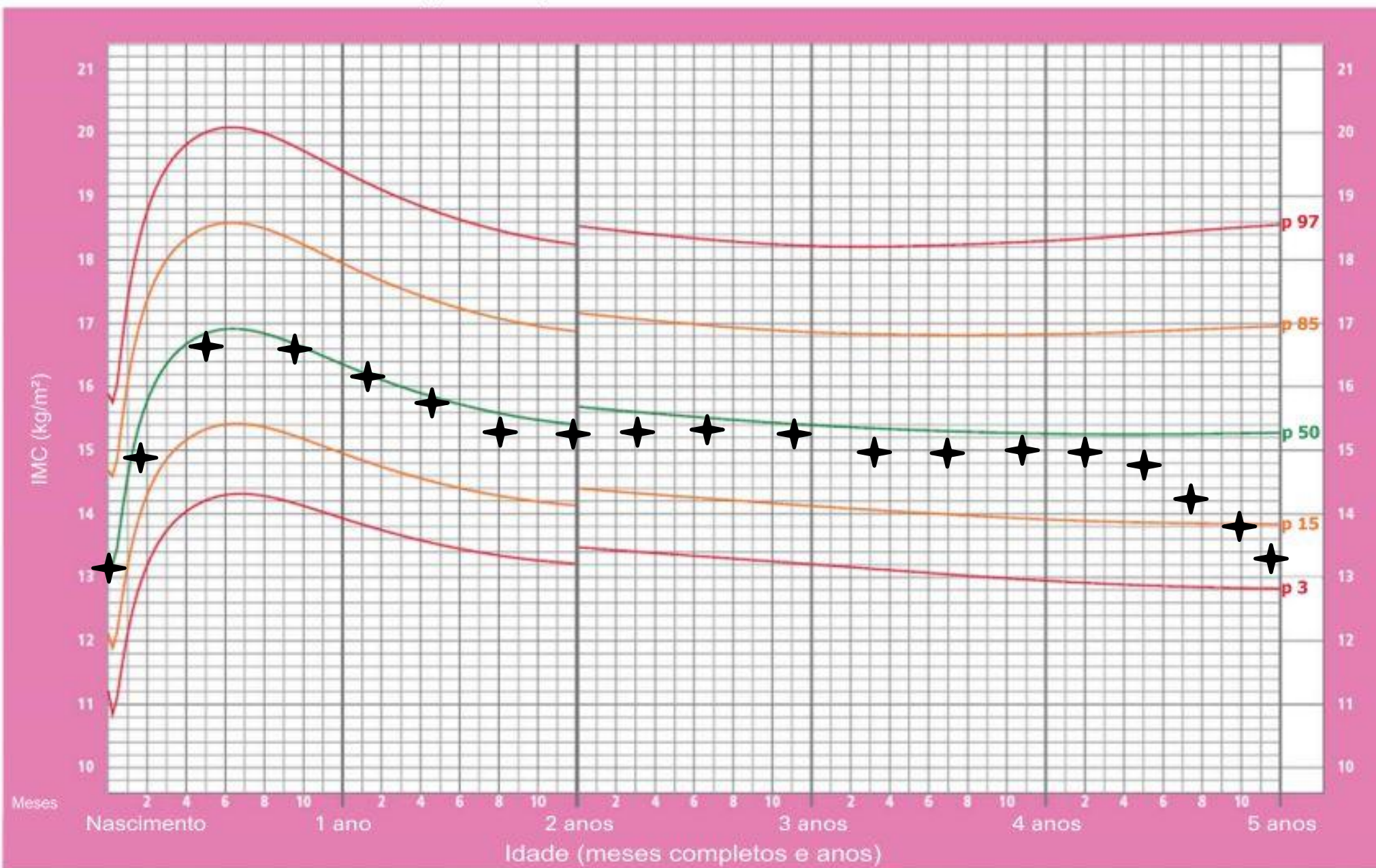
- História de parto e nascimento: a termo, sem intercorrências neonatal
- História de saúde: dermatites atópicas, bronqueolites
- Amamentação até os 2 anos e meio
- IA: sempre difícil, mas aceitava alimentos amassados e misturados (legumes, batata, carnes). Mantinha bom crescimento. Aos 4 anos, escutou a tia contar que uma criança engasgou com salsicha e morreu. Foi a partir daí que vou diminuindo seu repertório alimentar. Refere sensação que vai engasgar, que o alimento para na garganta. Tem nojo de alguns alimentos

- Pais sempre perceberam sintomas ansiosos como medo de dormir sozinha no seu quarto, teve atraso no desfralde (5 anos). Acorda muito a noite. Após a história da tia, ela piorou os sintomas. Dizem que sempre foi difícil ela comer, já forçaram, deixaram ela de castigo e viram apenas piora do quadro.
- Atualmente não brigam mais e oferecem só o que ela aceita
- Relatório escolar: desempenho regular, muito distraída e sonolenta na escola. Precisa trazer lancheira de casa para se alimentar. Escola prepara omelete todos os dias no almoço.

- EN: IMC/I -1.79, E/I -0.39
- Últimos exames de sangue: Tg aumentado, ferritina (limítrofe), B12 (limítrofe)
- HI: a cada 2 dias
- Acompanha com psicóloga pelos sintomas de medo, nunca fez tto para TARE

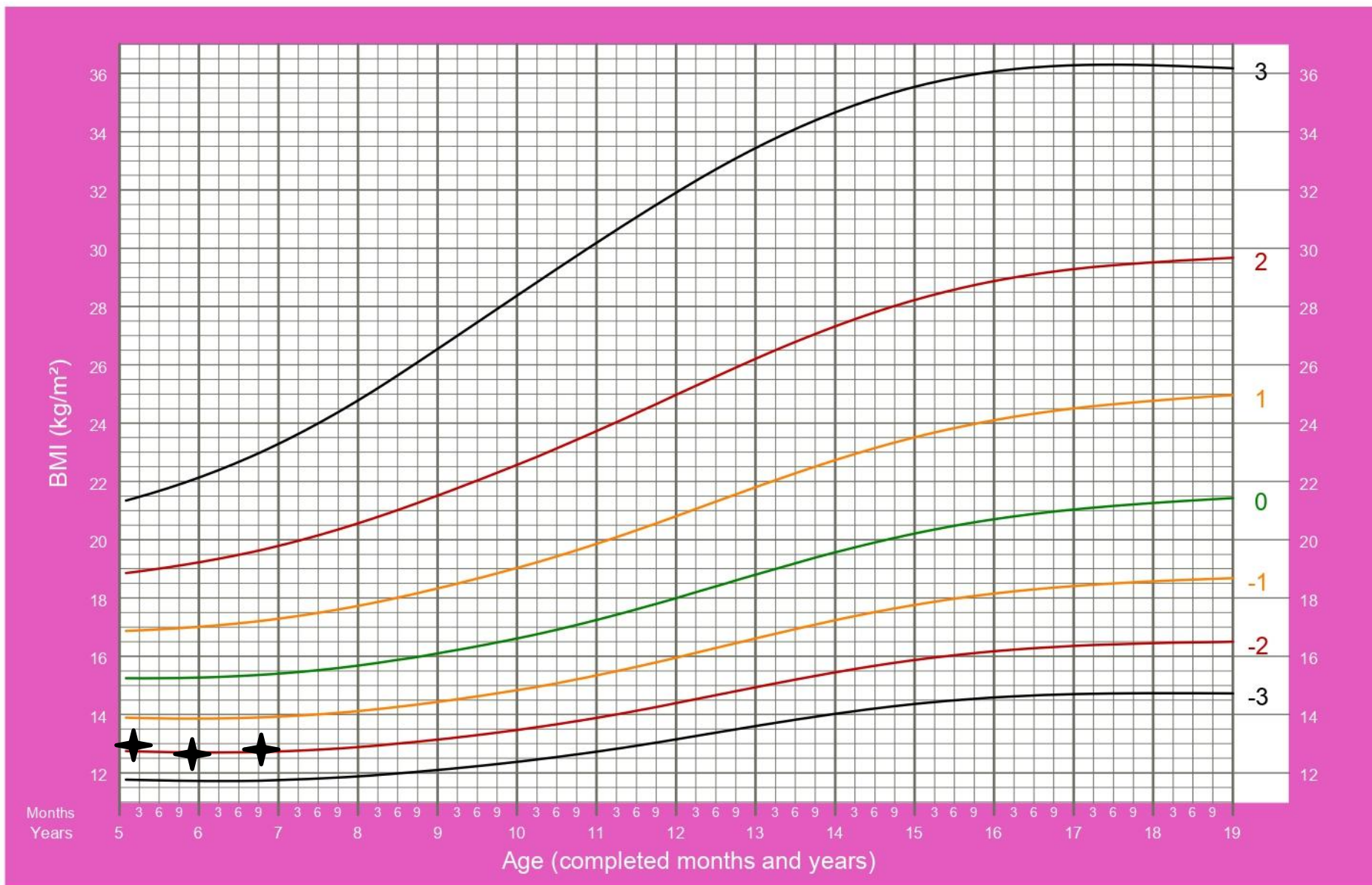
IMC por Idade MENINAS

Do nascimento aos 5 anos (percentis)



BMI-for-age GIRLS

5 to 19 years (z-scores)



PARDI



Published in final edited form as:

Int J Eat Disord. 2019 April ; 52(4): 378–387. doi:10.1002/eat.22958.

Development of the Pica, ARFID, and Rumination Disorder Interview, a multi-informant, semi-structured interview of feeding disorders across the lifespan: A pilot study for ages 10 to 22

Rachel Bryant-Waugh, DPhil^{1,2}, Nadia Micali, MD, PhD^{2,3}, Lucy Cooke^{1,2}, Elizabeth A. Lawson, M.D.^{4,5}, Kamryn T. Eddy, PhD^{6,7}, and Jennifer J. Thomas, PhD^{6,7}

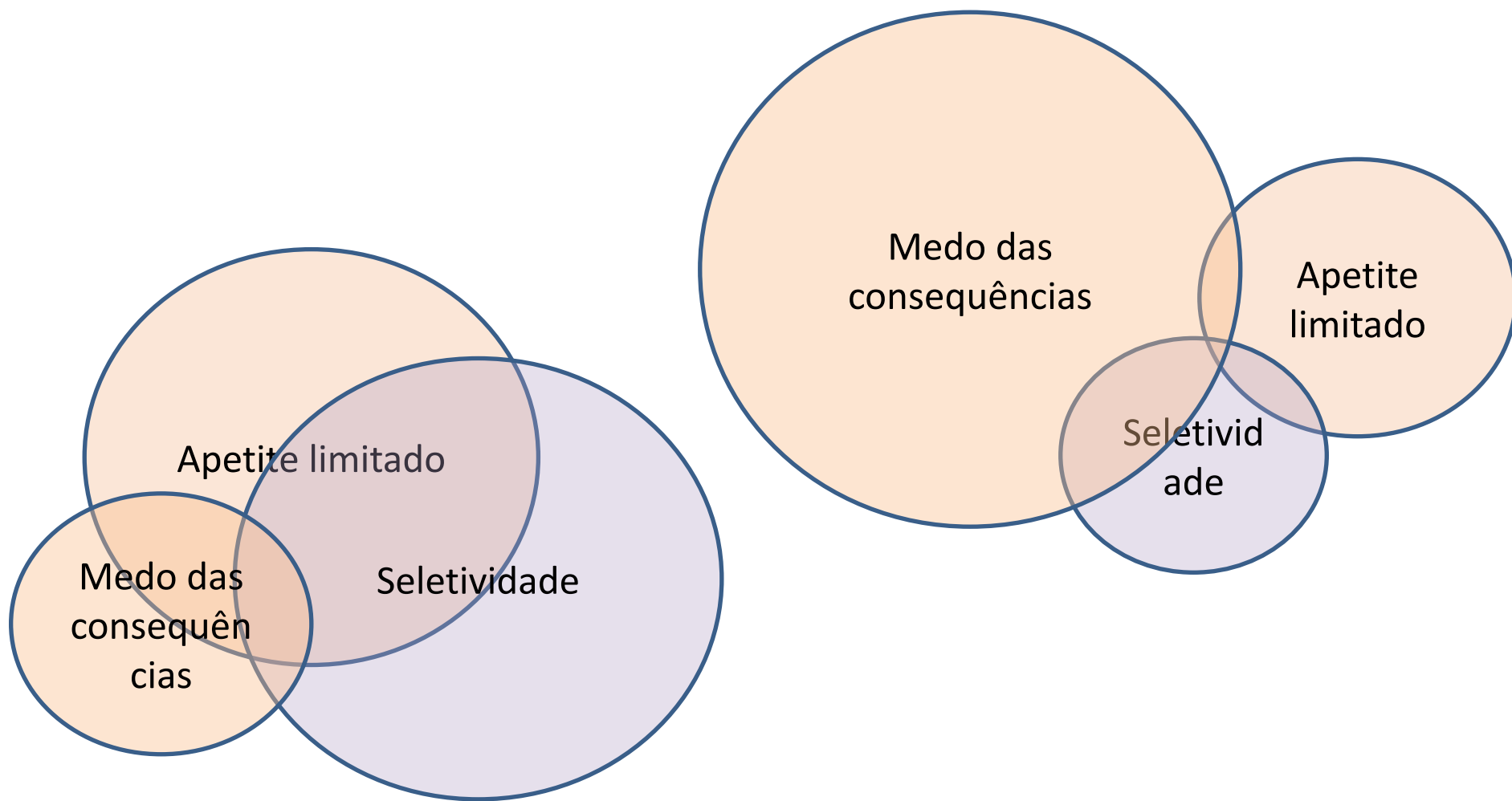
¹Feeding Disorders Team, Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust, London, UK ²Great Ormond Street Institute of Child Health, University College London, London, UK ³Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Geneva, Switzerland.

⁴Neuroendocrine Unit, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA ⁵Department of Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA, USA ⁶Eating Disorders Clinical and Research Program, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA ⁷Department of Psychiatry, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

- **4 versões:**
- 1- Pais/cuidadores para crianças de 2-3 anos
- 2- Pais/cuidadores para crianças de 4 anos ou mais
- 3- Crianças 8-13 anos
- 4- 14 anos ou mais (adultos)

Primeiras avaliações

- Avaliação do psiquiatra: TARE, sintomas de ansiedade e TDHA (?)
- PARDI: 3 subtipos (sensorial, pouco apetite e medo de consequências aversivas)



(Thomas & Eddy, 2019, adaptado ICED 2020)

Primeiros passos do tratamento

- Qual o subtipo de maior influência?
- Avaliações iniciais e encaminhamentos:
- Descartar algo orgânico: fono, TO, gastro?
- Planejamento de tratamento:
- Psicoeducação aos pais
- Estruturação de uma rotina de horários de refeição, tela, sono e atividades
- Retirada de belisco
- Levar a paciente a sentar à mesa e realizar refeições em família
- Retirada da tela no momento da refeição
- Apoio aos pais para aumentar SUPORTE e diminuir as acomodações

Recusa o que
tem no almoço

Comportamento de
recusa\evitação
da comida

Família
resolve o
problema

Pais preparam
o alimento
seguro

Manutenção
dos sintomas

Redução do
estresse a
curto prazo

Não é exposto
a situações de
aprendizado

continua
dependência da
regulação dos
pais

Ciclo de acomodação no
TARE



Mecanismo mantenedor TARE

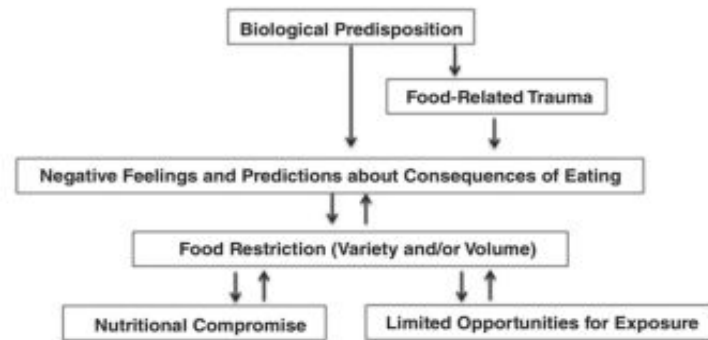


Fig 4.1 General cognitive-behavioral model of ARFID

A ACOMODAÇÃO FAMILIAR REFERE-SE ÀS MANEIRAS PELAS QUAIS OS PAIS E OUTROS MEMBROS DA FAMÍLIA MUDAM SEU PRÓPRIO COMPORTAMENTO PARA AJUDAR SEU PARENTE COM UMA DOENÇA PSQUIÁTRICA A EVITAR OU ALIVIAR O SOFRIMENTO RELACIONADO À DOENÇA

Avaliações

- FONO: hipotonia facial devido a falta de mastigação, porém consegue realizar.
- TO: sensibilidade sensorial apenas aos alimentos. Não fecha par TPS
- GASTRO: solicitação de endoscopia e exame de sangue. Prescrição de Peg-Lax Pó Solução Oral (HD: esofagite eosinofílica)
- Psiquiatria: solicitação relatório psico e prescrição de ansiolítico. Irá dar continuidade a avaliação de TDAH. Encaminhamento para psicoterapia para os pais para ajuda no manejo diário

Segundo momento do tratamento

- Rotina bem estruturada das refeições e das atividades
- Introdução de suplementação hipercalórica e hiperproteica+ polivitamínico com ferro
- Aumento progressivo do volume de comida e substituição do suco por água
- Início de pequenas flexibilizações em torno dos alimentos aceitos: retirada de embalagens, mudança de utensílios, cortes e formatos dos alimentos
- Modelo de divisão de responsabilidades
- Terapia individual focada em identificação das emoções existentes nas pequenas mudanças que estão acontecendo
- Terapia familiar: família com segurança para lidar com a birra e dar o devido suporte para os pequenos enfrentamentos

PLANO DE AÇÃO

1

OFERECER
EQUILÍBRIO DOS
GRUPOS
ALIMENTARES
NAS REFEIÇÕES
PRINCIPAIS

2

VARIAR ENTRE OS
ALIMENTOS QUE
ELE ACEITA

3

REALIZAR AS
PEQUENAS
FLEXIBILIZAÇÕES
MESMOS
ALIMENTOS
OUTROS
FORMATOS

4

REALIZAR AS
PEQUENAS
FLEXIBILIZAÇÕES
MESMOS
ALIMENTOS OUTRAS
MARCAS

5

EXPOSIÇÃO AOS
ALIMENTOS QUE
AINDA NÃO ACEITA
PARA QUE VEJA

6



ALIMENTO QUE
ACEITA/GOSTA



REFEIÇÃO DA FAMÍLIA



EXPOSIÇÃO ALIMENTOS
QUE NÃO ACEITA

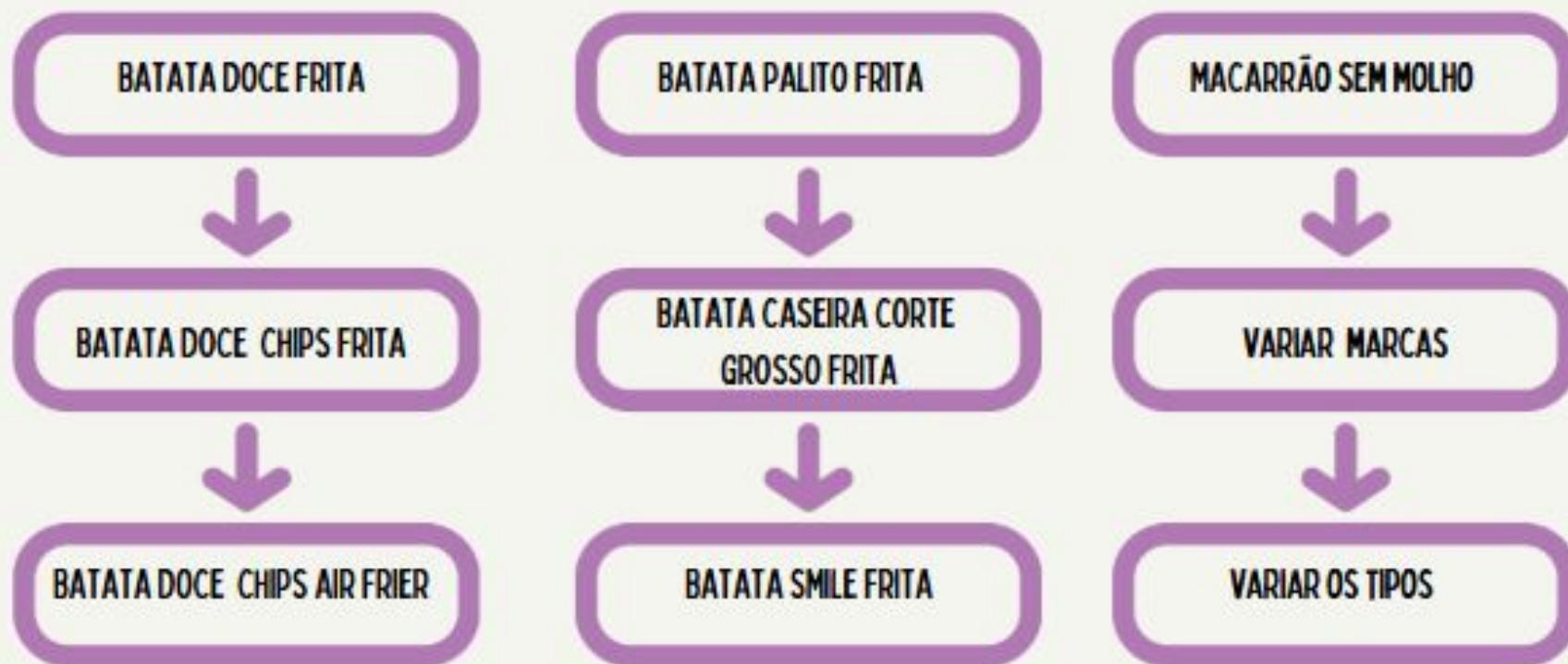


COMO
OFERECER?

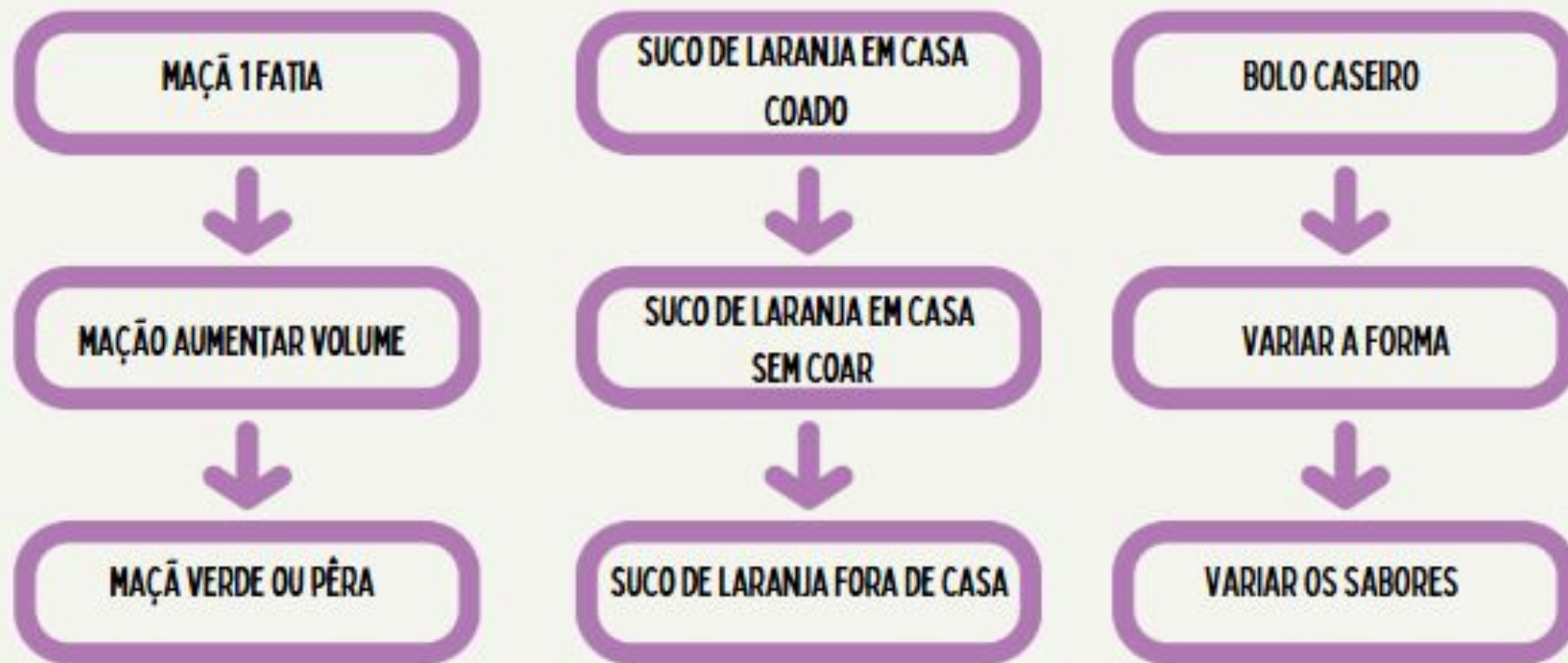
Terceiro momento

- Gastro: confirma HD esofagite eosinofílica e inicia tratamento medicamentoso
- Início do food chaining :
 - - Panqueca □ Waffle □ pão sírio □ wrapp
- Omelete □ omelete cortado em círculos □ omelete com poucos recheios □ aumento do recheio □ provar recheio separado (ex do frango desfiado- nuggets de frango)
- Omelete □ ovo mexido □ ovo frito
- Chocolate branco □ chocolate branco com gosto de chocolate ao leite □ aumento das gotas □ chocolate ao leite
- Suco de pêssego cx □ retirada da caixinha □ variar sabor □ suco de fruta natural peneirado □ suco natural

SUGESTÕES PARA PEQUENAS AMPLIAÇÕES E FLEXIBILIZAÇÕES



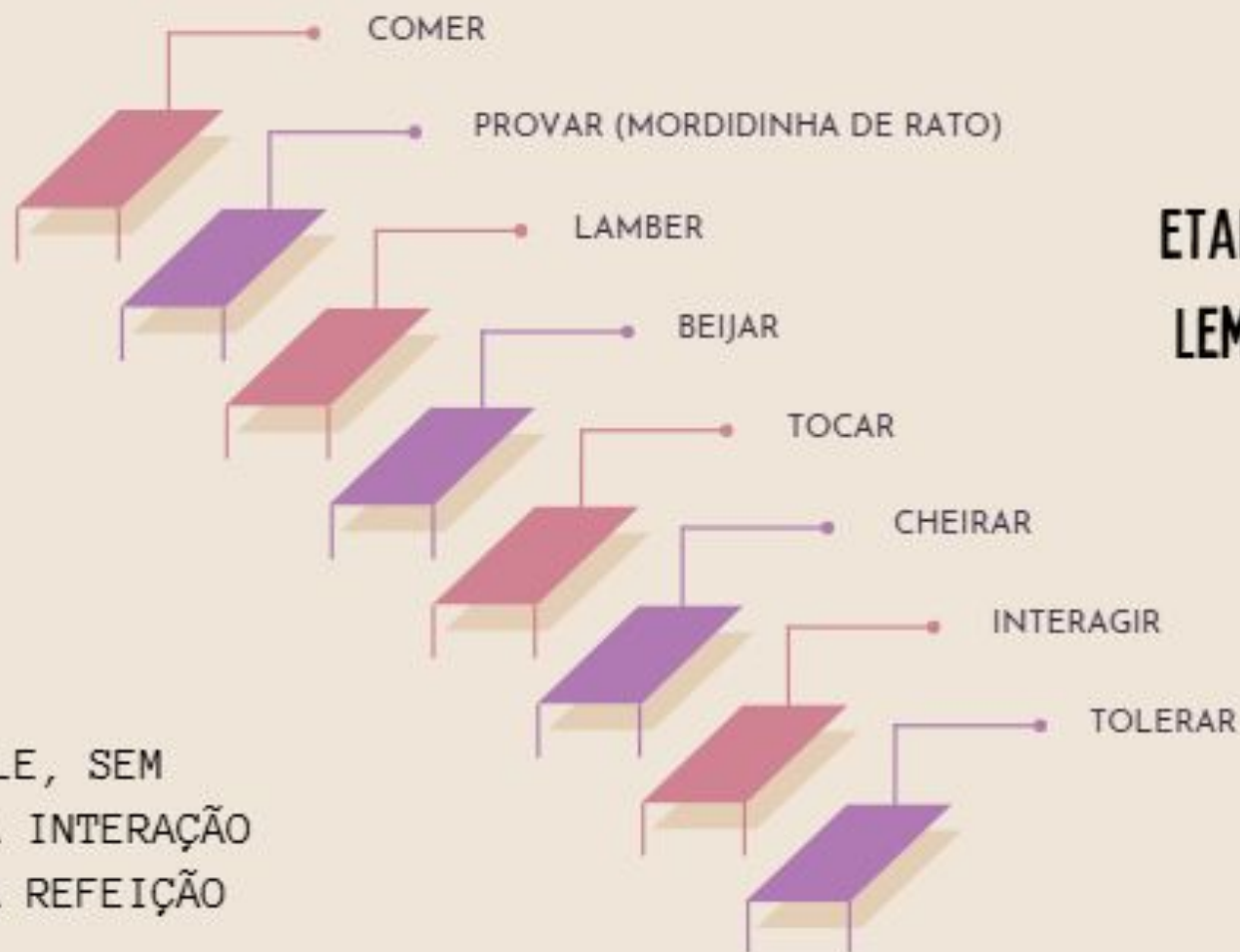
SUGESTÕES PARA PEQUENAS AMPLIAÇÕES E FLEXIBILIZAÇÕES



Flexibilização cognitiva



ESTIMULE, SEM
PRESSÃO, A INTERAÇÃO
DURANTE A REFEIÇÃO



**ETAPAS PARA COMER:
LEMBRE-SE QUE É UM
PROCESSO**

DURANTE A SEMANA



Alimento/Tarefas	tolerou perto	tocou/ interagiu	cheirou	aproximou da boca ou lambeu
CROQUETE OFNER				
MANIPULAR A CENOURA				
TEMPURA DE CENOURA				
ABACAXI				
CARDÁPIO DA VIAGEM OLHAR ATENTO E CURIOSO				

Atividade culinária



Quarto momento

- Atividade de aproximação lúdica com os novos alimentos
- Escolha semanal de alimentos para conhecer
- Ambiente seguro e sem pressão: nível de interação que conseguir fazer □ tarefa para casa
- Educação sobre sinais de fome e saciedade

SUDS: sintomas ansiosos

ESCALA : QUANTO EU TOLERO A
EXPERIÊNCIA?

10- INSUPORTÁVEL

9- MUITO DESCONFORTO

8- MÉDIO DESCONFORTO

7- LEVE DESCONFORTO

6- DESCONFORTO

5- NEUTRO

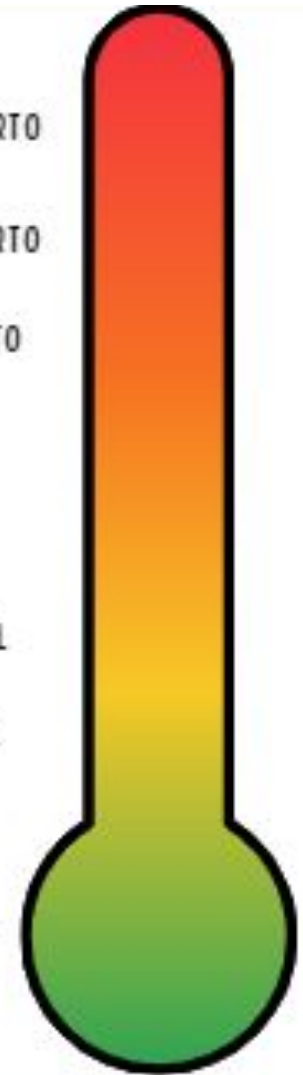
4- POUCO TOLERÁVEL

3- MÉDIO TOLERÁVEL

2- LEVE TOLERÁVEL

1- MUITO TOLERÁVEL

0- AGRADÁVEL



Escalas

ESCALA DE CONFORTO



ESCALA DE MEDO



ESCALA DE NOJO



- Incorporar novos alimentos na rotina
- Familiaridade com os novos alimentos
- Alta: Atingir metas nutricionais modestas e pais com segurança para manejar o contexto alimentar



Obrigada!

@papos_e_pettyscos

CASO: Cauã W. S. S.

Nutricionista: Daniela Marchioreto

APRESENTAÇÃO DO PACIENTE



- **Data de Nascimento:** 19/06/2017
- **Idade:** 8 anos
- **Mãe:** Tamara S. S.
- **Pai:** Lucas W. S. S.
- Reside em São Paulo
- Estuda no período da manhã (7h-11h30)

HISTÓRICO ALIMENTAR INICIAL



- **Aleitamento materno:** exclusivo até 6 meses; fórmula até 1 ano e 6 meses.
- **Introdução alimentar:** início aos 5 meses com sucos e papas amassadas, sob orientação médica.
 - Foram oferecidos todos os grupos alimentares, exceto leguminosas e folhas.
 - Realizava refeições no cadeirão, com uso de distração e junto à família.
- **Desenvolvimento global:** adequado nessa fase.

HISTÓRIA DA QUEIXA

- **Por volta dos 9 meses:** Ao ingressar na creche passa a vomitar com frequência após ser forçado a comer.
 - Frequentemente retorna da escola com roupas sujas e é assim que os pais começam a desconfiar de alguma inadequação.
 - Início de medo intenso de talheres, chegando a chorar e soluçar ao vê-los; se recusa a comer qualquer alimento com talheres.
- **Aos 12 meses:** Início da recusa alimentar mais acentuada (deixa de aceitar alimentos antes aceitos), se recusa a sentar-se à mesa e apresenta diminuição do apetite.
 - **Relato da mãe:** “Se colocasse qualquer coisa na boca, ele vomitava; se não insistisse, ele passava o dia sem comer.”
- Família procura ajuda do pediatra que minimiza a situação.
- Aos 2 anos: família busca orientação nutricional.

ACOMPANHAMENTOS PRÉVIOS



- Acompanhamento com nutricionista.
- Acompanhamento psicológico
- Acompanhamento com terapeuta ocupacional.
- ❖ Acompanhamentos com TO e psicólogo suspensos pela família quando souberam que fariam parte do nosso tratamento.

TARE: AVALIAÇÃO DE SUBTIPOS

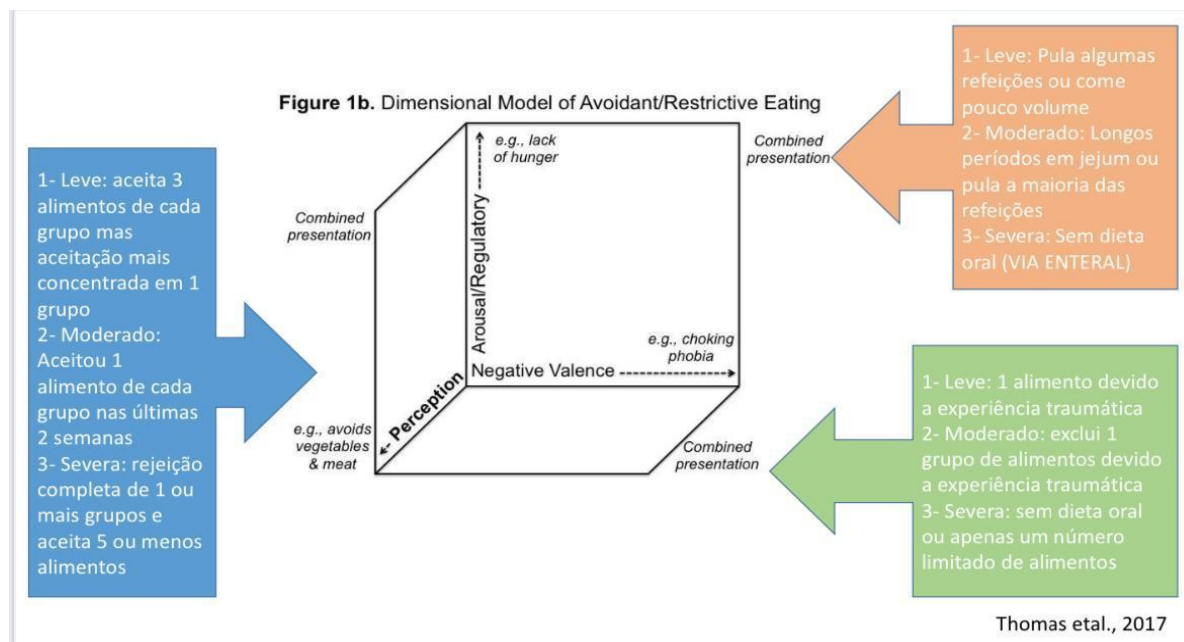
- Subtipo Tare (PARDI): Sensorial

Diagnóstico de TARE	Itens ≥ 4	Perfil Sensorial		Falta de Interesse		Medo de Consequências Aversivas	
SIM	SIM	1	SIM	1	NÃO	0	NÃO

- **Subtipo segundo nossa avaliação:** Sensorial / Medo de Consequências Aversivas (?) – Embora não tenha pontuado no PARDI apresentou episódios de vômito e aversão a utensílios iniciados na creche.

TARE: AVALIAÇÃO DE SUBTIPOS

- **Classificação Jennifer Thomas:** subtipo Sensorial (Severa): rejeição completa de alimentos energéticos, construtores e reguladores (almoço e jantar)



LISTA DE ACEITAÇÃO – café e lanches

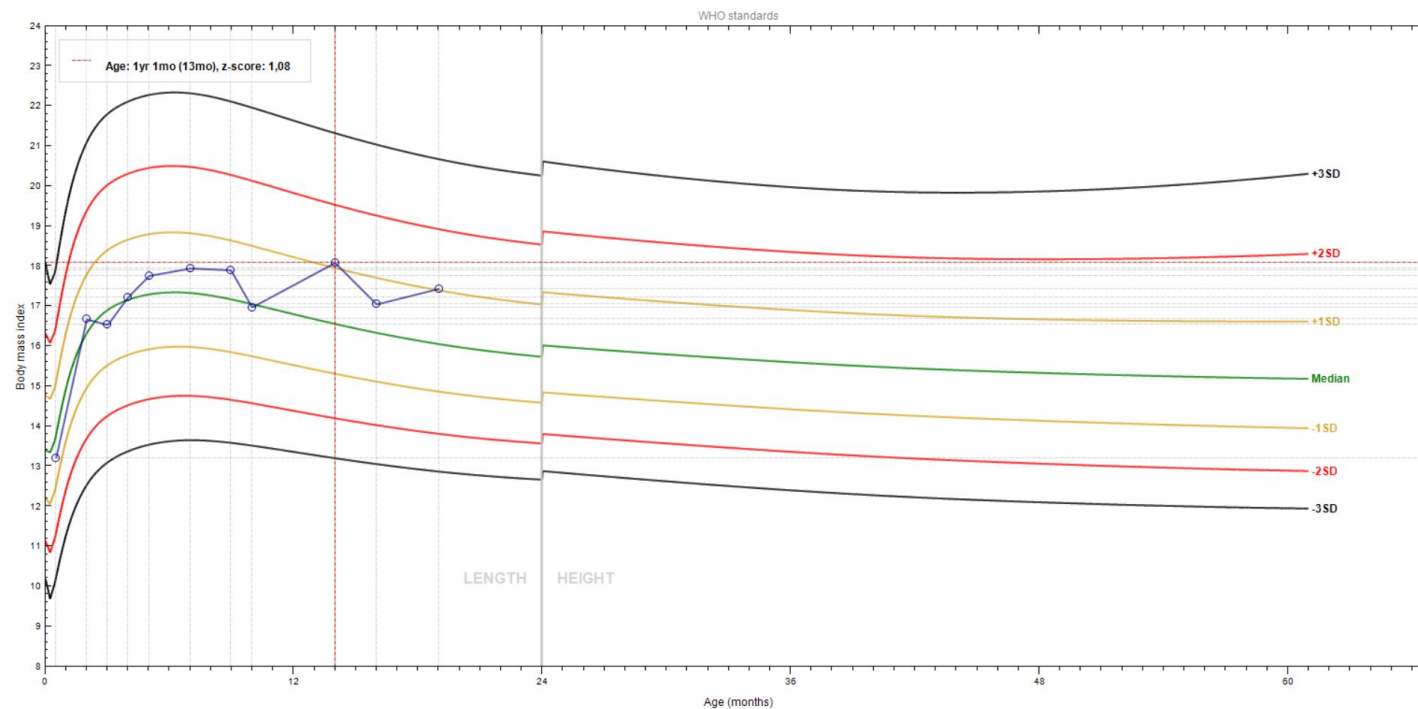
	ENERGÉTICOS	CONSTRUTORES	REGULADORES	OUTROS
ADORA	Biscoito de polvilho, cereal matinal (Sucrilhos), salgadinho de pacote variados, pipoca	Leite fermentado	-	-
ACEITA	Biscoito água e sal, biscoito simples sem recheio, pão francês (fresco, quente e apenas a casca), torrada	Leite (apenas preparado na mamadeira), amendoim industrializado (doce e salgado)	suco de laranja (Natural One),	Mel

LISTA DE ACEITAÇÃO – almoço e jantar

	ENERGÉTICOS	CONSTRUTORES	REGULADORES	OUTROS
ADORA	-	-	-	-
ACEITA	Batata frita (apenas a do Mc Donald's e se estiver quente), batata palha	-	-	Pastel de vento

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

IMC/Idade (2 meses – 1 ano e 7 meses)



AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL INICIAL

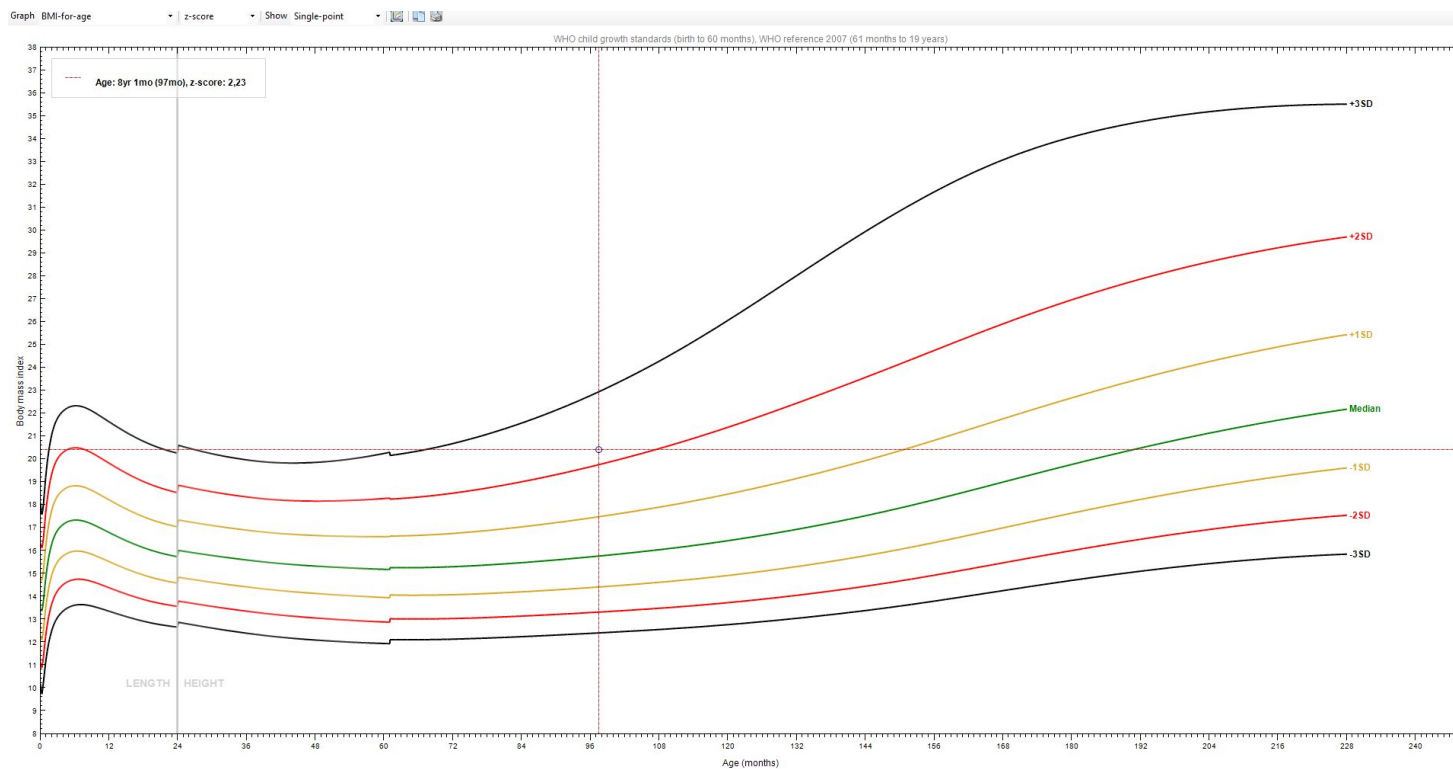


Data da Aferição: 23/04/2025

- **Peso:** 35,1 kg
- **Estatura:** 132 cm
- **IMC:** 20,1 kg/m²
- **E/I (z-score):** 1,00
- **P/I (Z-score):** 2,18
- **IMC/I (z-score):** 2,22
- **Classificação EN:** Obesidade

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

IMC/Idade (em abril de 2025)



AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL ATUAL

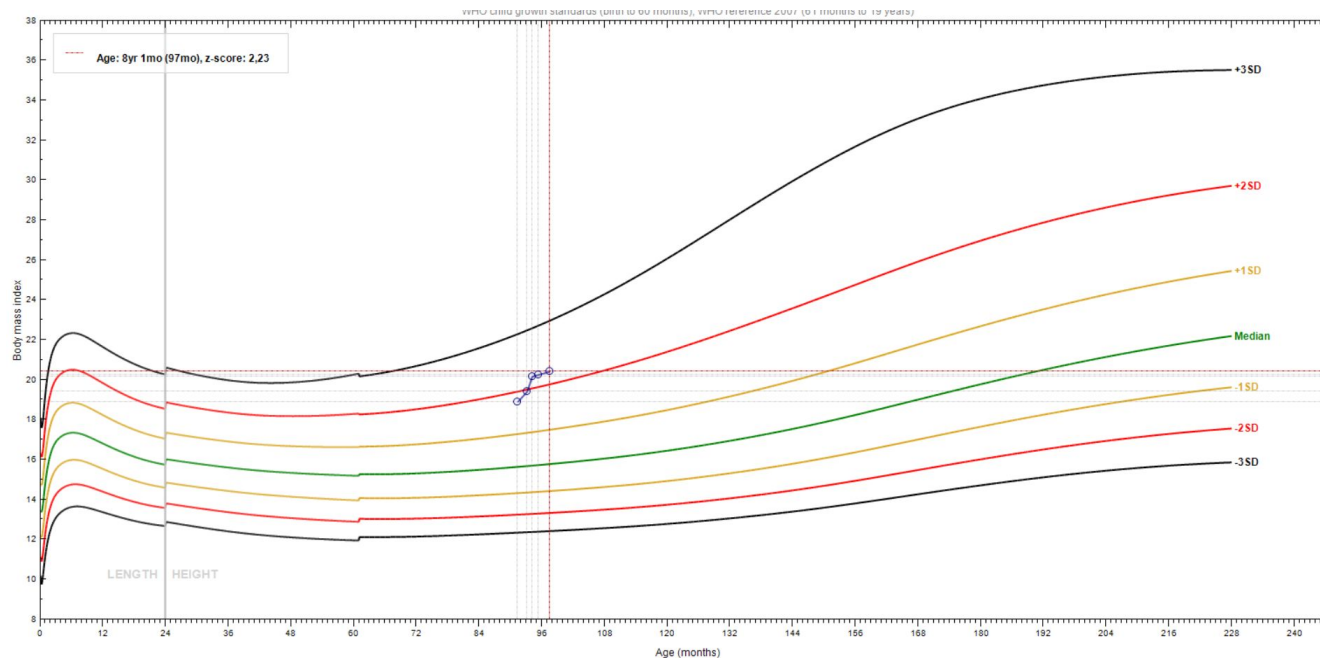


Data da Aferição: 06/08/2025

- **Peso:** 36,1 kg
- **Estatura:** 133 cm
- **IMC:** 20,4 kg/m²
- **E/I (z-score):** 0,88
- **P/I (Z-score):** 2,13
- **IMC/I (z-score):** 2,23
- **Classificação EN:** Obesidade

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

IMC/Idade (abril-agosto de 2025)



AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS



- **Atividade física:**
Jiu Jitsu – 2 x semana
- **TMB (FAO/OMS - 2001): 1.301 kcal**
- **GET(FAO/OMS - 2001):**
FA moderada (1.64): 1662 kcal

REGISTRO ALIMENTAR (dia 1)

Data	Hora <u>Início</u>	Hora Final	Utensílios utilizados	Quantidade	Alimento Preparação	Marca	Local	Presença De distração	Com quem
07/01/25	10:30 AM	11:10 AM	Mixer (batedor) Mamadeira	300ml	- 250 ml Leite - 1 banana - 2 colheres cereal - 1 colher rasa de açúcar - 2 colheres de Suplemento	Leite integral Jussara Cereal Neston Açúcar refinado Sustagen Baunilha	sofá	TV	Mãe
07/01/25	12:00 PM	12h40 PM	Não utilizou Comeu com a mão	150grs 150ml	Cereal matinal Leite fermentado	Sucrilhos Frutap	Sala Brincando Com amigo	Brincando Com lego	amigo
07/01/25	15:00 PM	15:30 PM	Não utilizou	90 grs 150 ml	Salgadinho Suco Laranja	Fofura Sabor presunto ONE	Sala Brincando Com amigo	TV	amigo
07/01/25	18:00 PM	18:40 PM	Mixer (batedor) Mamadeira	300ml	- 250 ml Leite - 1 banana - 2 colheres cereal - 1 colher rasa de açúcar - 2 colheres de Suplemento	Leite integral Jussara Cereal Neston Açúcar refinado Sustagen Baunilha	Sofá	TV	Pai
07/01/25	21:00 PM	21:45 PM	Mixer (batedor) Mamadeira	300ml	- 250 ml Leite - 1 banana - 2 colheres cereal - 1 colher rasa de açúcar - 2 colheres de Suplemento	Leite integral Jussara Cereal Neston Açúcar refinado Sustagen Baunilha	Sofá	TV	Mãe

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR

Resumo de nutrientes



PTN	?	51,27 g (8,3 %)
CHO	?	465,45 g (75,1 %)
LIP	?	45,66 g (16,6 %)
Kcal		2.422 kcal

Resumo de nutrientes



PTN	?	68,16 g (8,2 %)
CHO	?	554,20 g (67,1 %)
LIP	?	90,71 g (24,7 %)
Kcal		3.245 kcal

Resumo de nutrientes



PTN	?	48,39 g (9,0 %)
CHO	?	393,22 g (73,0 %)
LIP	?	43,05 g (18,0 %)
Kcal		2.126 kcal

Média consumo calórico diário: 2597 kcal

GET: 1662 kcal

Em média + 900 kcal/dia

AVALIAÇÃO DE MICRONUTRIENTES DO REGISTRO ALIMENTAR



⊖ Micronutrientes Valores e DRI

Micronutrientes	Valor atual	Referência	DRI (Crianças de 4-8 anos)
Açúcar Total	131,04 g		
Cálcio	1.422,2 mg	↓ 800 mg	
Colesterol	87,08 mg		
Ferro	37,12 mg	↓ 10 mg	
Fibra alimentar	12,56 g	↑ 25 g	
Fósforo (P)	1.273,42 mg	↓ 500 mg	
G. Monoinsaturada	7,02 g		
G. Poli-insaturada	1,77 g		
G. Saturada	19,62 g		
G. Trans	1 g		
Magnésio	208,85 mg	↓ 130 mg	
Manganês	1,56 mg	↓ 1,5 mg	
Potássio	2.848,64 mg	↑ 3.800 mg	
Selênio	38,01 mcg	↓ 30 mcg	
Sódio	2.311,65 mg	↓ 1.900 mg	
Vitamina A (Retinol)	1.649,96 mcg	↓ 400 mcg	
Vitamina B1 (Tiamina)	3,35 mg	↓ 0,8 mg	
Vitamina B12 (Cobalamina)	7,89 mcg	↓ 1,2 mcg	
Vitamina B2 (Riboflavina)	5,04 mg	↓ 0,6 mg	
Vitamina B3 (Niacina)	40,1 mg	↓ 8 mg	
Vitamina B6 (Piridoxina)	4,97 mg	↓ 0,6 mg	
Vitamina B9 (Ácido fólico)	208,26 mcg	↓ 200 mcg	
Vitamina C (Ácido ascórbico)	214,18 mg	↓ 25 mg	
Vitamina D (Calciferol)	20,92 mcg	↓ 5 mcg	
Vitamina E (Tocoferol)	11,82 mg	↓ 7 mg	
Zinco	28,76 mg	↓ 5 mg	

Legenda: Adequado Pouco inadequado Inadequado

⊖ Micronutrientes Valores e DRI

Micronutrientes	Valor atual	Referência	DRI (Crianças de 4-8 anos)
Açúcar Total	135,81 g		
Cálcio	2.326,23 mg	↓ 800 mg	
Colesterol	99,14 mg		
Ferro	39,19 mg	↓ 10 mg	
Fibra alimentar	18,47 g	↑ 25 g	
Fósforo (P)	1.471,66 mg	↓ 500 mg	
G. Monoinsaturada	7,87 g		
G. Poli-insaturada	1,88 g		
G. Saturada	36,39 g		
G. Trans	1,13 g		
Magnésio	246,63 mg	↓ 130 mg	
Manganês	1,57 mg	↓ 1,5 mg	
Potássio	2.802,41 mg	↑ 3.800 mg	
Selênio	41,78 mcg	↓ 30 mcg	
Sódio	2.439,64 mg	↓ 1.900 mg	
Vitamina A (Retinol)	1.768,93 mcg	↓ 400 mcg	
Vitamina B1 (Tiamina)	3,56 mg	↓ 0,8 mg	442%
Vitamina B12 (Cobalamina)	8,59 mcg	↓ 1,2 mcg	
Vitamina B2 (Riboflavina)	5,43 mg	↓ 0,6 mg	
Vitamina B3 (Niacina)	42,74 mg	↓ 8 mg	
Vitamina B6 (Piridoxina)	5,03 mg	↓ 0,6 mg	
Vitamina B9 (Ácido fólico)	215,8 mcg	↓ 200 mcg	
Vitamina C (Ácido ascórbico)	175,48 mg	↓ 25 mg	
Vitamina D (Calciferol)	22,54 mcg	↓ 5 mcg	
Vitamina E (Tocoferol)	11,86 mg	↓ 7 mg	
Zinco	32,94 mg	↓ 5 mg	

Legenda: Adequado Pouco inadequado Inadequado

⊖ Micronutrientes Valores e DRI

Micronutrientes	Valor atual	Referência	DRI (Crianças de 4-8 anos)
Açúcar Total	147,06 g		
Cálcio	1.990,81 mg	↓ 800 mg	
Colesterol	75,03 mg		
Ferro	19,67 mg	↓ 10 mg	
Fibra alimentar	9,37 g	↑ 25 g	
Fósforo (P)	1.201,91 mg	↓ 500 mg	
G. Monoinsaturada	6,18 g		
G. Poli-insaturada	1,67 g		
G. Saturada	16,76 g		
G. Trans	0,87 g		
Magnésio	226,97 mg	↓ 130 mg	
Manganês	1,59 mg	↓ 1,5 mg	
Potássio	2.278,66 mg	↑ 3.800 mg	
Selênio	34,49 mcg	↓ 30 mcg	
Sódio	743,95 mg	↓ 1.900 mg	
Vitamina A (Retinol)	609,6 mcg	↓ 400 mcg	
Vitamina B1 (Tiamina)	1,59 mg	↓ 0,8 mg	
Vitamina B12 (Cobalamina)	4,8 mcg	↓ 1,2 mcg	
Vitamina B2 (Riboflavina)	2,76 mg	↓ 0,6 mg	
Vitamina B3 (Niacina)	19,51 mg	↓ 8 mg	
Vitamina B6 (Piridoxina)	2,41 mg	↓ 0,6 mg	
Vitamina B9 (Ácido fólico)	200,49 mcg	↓ 200 mcg	
Vitamina C (Ácido ascórbico)	138,88 mg	↓ 25 mg	
Vitamina D (Calciferol)	19,3 mcg	↓ 5 mcg	
Vitamina E (Tocoferol)	11,77 mg	↓ 7 mg	
Zinco	13,06 mg	↓ 5 mg	

Legenda: Adequado Pouco inadequado Inadequado

EXAMES LABORATORIAIS (MAIO/2025) E DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS



- **Perfil lipídico alterado**, com **colesterol total, LDL e triglicérides elevados**.
- **Maiores impactos da restrição**: Alimentos energéticos, construtores e regulares de almoço e jantar.
- **Deficiência de micronutrientes segundo o registro alimentar de 3 dias**: fibras e potássio.
- **Suplementação**: Faz uso de Sustagen, Zirvit Kids, Addera e vitamina C.
- Não há necessidade de recuperação nutricional.

QUEIXAS DO TGI

- Sem queixas: evacua todos os dias, sem sinal de constipação.

ASPECTOS FAMILIARES

- Reside com os pais.
- Não faz refeições com a família, come no sofá ou na cama em frente a TV.
- Avós acompanham algumas refeições.

DINÂMICA ALIMENTAR INÍCIO DO TRATAMENTO



- Não participava de refeições em família.
- Não havia beliscos entre as refeições.
- Demonstrava aversão ao toque em alimentos, mas participa ocasionalmente de preparações culinárias.
- Segundo a mãe, o clima das refeições era tenso e estressante, especialmente pela duração da mamadeira (quase 1h).
- Na escola, consome apenas os alimentos levados de casa.

DINÂMICA ALIMENTAR INÍCIO DO TRATAMENTO



- Apresenta dificuldades no uso adequado de talheres e ainda utiliza mamadeira.
- Pais relatavam dificuldade para mantê-lo sentado à mesa durante as refeições.
- Não se alimenta fora de casa; os responsáveis sempre levam os próprios alimentos dele.

LINHA DO TEMPO DO TRATAMENTO

abril

- Aplicação de questionários para mapear ambiente alimentar e comportamentos.
- Revisão detalhada da lista de aceitação.
- Elaboração do primeiro cardápio com os pais, promovendo previsibilidade nas refeições.

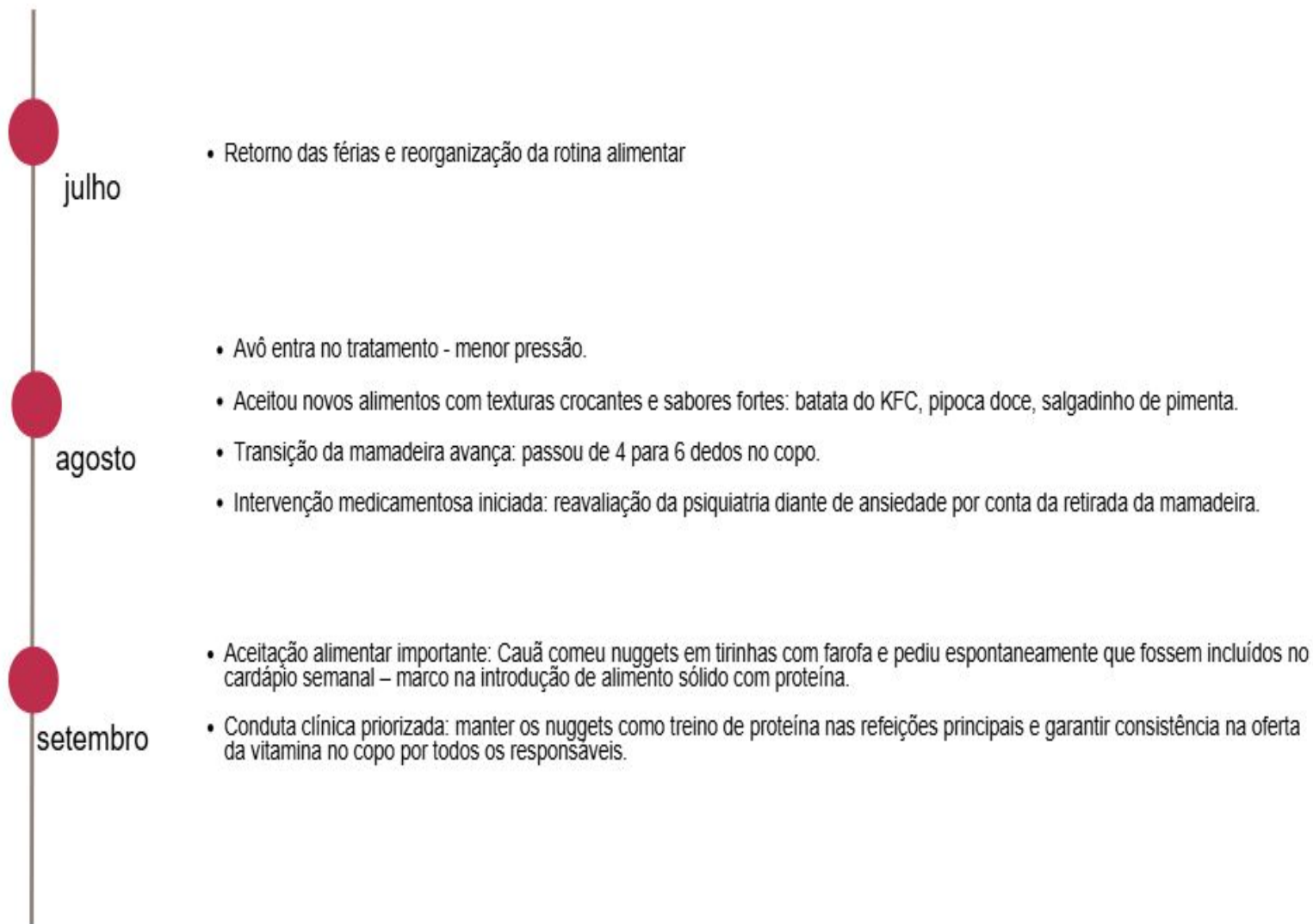
maio

- Redução do tempo de consumo da mamadeira e maior engajamento no novo cardápio.
- Composição da mamadeira modificada (retirada Neston) para adequação de valor energético.
- Estratégias lúdicas reforçadas para tornar o tempo de mesa mais positivo.
- Início da exposição a novas marcas para flexibilizar o repertório alimentar.

junho

- Pai trocou o suplemento da mamadeira sem orientação, gerando perda de vínculo e necessidade de retomar confiança familiar.
- Redução de 2 mamadeiras no jantar, substituídas por batata e suco.
- Novos alimentos aceitos: torrada com azeite e orégano, farofa e pão francês.
- Orientação à família para validação dos esforços de Cauã.

LINHA DO TEMPO DO TRATAMENTO



PLANO ALIMENTAR ATUAL



REFEIÇÃO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
Café da Manhã (6:10-6:30)	vitamina sentado à mesa (8 dedos no copo)	vitamina sentado à mesa (8 dedos no copo)	vitamina sentado à mesa (8 dedos no copo)	vitamina sentado à mesa (8 dedos no copo)	vitamina sentado à mesa (8 dedos no copo)	vitamina sentado à mesa (8 dedos no copo)	vitamina sentado à mesa (8 dedos no copo)
Lanche (9:00-9:15)	sucrilhos suco de laranja	passatempo Yakult	bolacha maria suco de laranja	trakinas Yakult	oreo suco de laranja	maisena Yakult	club social suco de laranja
Almoço (12:00 -12:20)	vitamina sentado à mesa biscoito de leite	vitamina sentado à mesa pipoca	vitamina sentado à mesa farofa	vitamina sentado à mesa bolacha água e sal	vitamina sentado à mesa torrada com azeite e orégano	vitamina sentado à mesa pringles	vitamina sentado à mesa cebolitos
Lanche Tarde (15-16h)	Yakult club social	suco de laranja maisena	Yakult rosquinha de coco	suco de laranja sequilhos	Yakult pipoca	suco de laranja passatempo	Yakult sucrilhos
Jiu-Jitsu (18h00)		vitamina sentado à mesa (8 dedos no copo)		vitamina sentado à mesa (8 dedos no copo)			
Jantar (20h00)	farofa + nuggets em tirinhas + suco	batata chips + suco de laranja	batata + suco + paçoca	nuggets em tirinhas + batata chips + refri	batata + suco + paçoca	farofa + nuggets em tirinhas + suco	batata chips + suco de laranja